

سازمان شهدا – ولایت دایکندی

Shuhada Organization — Daikundi

کتاب قانون زبان

راهنمای جامع و عملی

Provincial Coordinator

در بخش صحت – با سناریوهای واقعی، تمرین و جواب مدل

پلان

نظارت

راپور

نسخه دوم – ویرایش شده، تصحیح شده و آماده نشر

۱۴۰۵ خورشیدی

«Working for a better tomorrow»

کتاب قانون زبان

راهنمای جامع و عملی Provincial Coordinator

سازمان شهدا – ولایت دایکندی

Shuhada Organization – Daikundi

«Working for a better tomorrow»

نسخه دوم – ویرایش شده، تصحیح شده و آماده نشر

۱۴۰۵ خورشیدی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پیشگفتار

درباره این کتاب

چگونه از این کتاب استفاده کنیم

نقشه راه ده فصل

فهرست اختصارات

فصل اول: ذهن یک Provincial Coordinator چگونه کار می‌کند؟

۱.۱. وظایف واقعی یک Provincial Coordinator

۱.۲ Planning - پلان‌سازی

۱.۳ Work Plan - پلان کاری

۱.۴ نظارت (Monitoring) - چطور و چرا؟

۱.۵ شاخص کلیدی عملکرد (KPI)

۱.۶ Risk و Issue - چرکان چیست؟

۱.۷ Prioritization - کدام کار اول؟

۱.۸ Follow-up - پیگیری

۱.۹ چرخه کار Coordinator - از اول تا آخر

۱.۱۰ اشتباهات رایج یک Coordinator

۱.۱۱ تمرین کوتاه

۱.۱۲ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل دوم: راپورنویسی و ارتباطات حرفه‌ای

۲.۱ راپورنویسی (Reporting) - چرا این قدر مهم است؟

۲.۲. راپور روایتی (Narrative Report)

۲.۳. راپور ماهوار و ربعوار (Monthly/Quarterly Report)

۲.۴. خلاصه اجرایی (Executive Summary)

۲.۵. پلان اقدام (Action Plan)

۲.۶. چالش‌ها و درس‌های آموخته‌شده (Challenges & Lessons Learned)

۲.۷. راپور حادثه‌ای (Incident Report)

۲.۸. راپورنویسی - اشتباهات رایج

۲.۹. تمرین کوتاه

۲.۱۰. خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل سوم: نظام صحتی افغانستان، HMIS، PPHD، MoPH و DHIS2

۳.۱. ساختار صحتی افغانستان

۳.۲. EPHS و BPHS

سیستم معلومات صحتی - HMIS ۳.۳

سیستم معلومات صحتی دیجیتال - DHIS2 ۳.۴

و اسناد اصلی Register ۳.۵

۳.۶. تمرین کوتاه

۳.۷. خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

۳.۸. نظام صحتی افغانستان امروز (۱۴۰۵) - چیزهایی که در کار روزمره می‌بینی

فصل چهارم: تدارکات، دوا، لوژستیک و دارایی‌ها

۴.۱. تدارکات (Procurement)

۴.۲. مصرف متوسط ماهانه (AMC)

۴.۳. موجودی (Stock) و Stock Card

۴.۴. نقطه سفارش مجدد (Reorder Point)

۴.۵. کمبود دوا (Stock-out) - چطور مدیریت کنیم؟

۴.۶ زمستانی‌سازی (Winterization)

۴.۷ مدیریت دارایی‌ها (Asset Management)

۴.۸ تمرین کوتاه

۴.۹ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل پنجم: مدیریت مالی

۵.۱ بودجه (Budget)

۵.۲ پلان‌شده در مقابل واقعی (Planned vs Actual)

۵.۳ تفاوت بودجه (Variance)

۵.۴ پیش‌پرداخت (Advance)

۵.۵ تصفیه پیش‌پرداخت (Advance Clearance)

۵.۶ اسناد حمایتی (Supporting Documents)

۵.۷ پول نقد (Cash) و مدیریت آن

۵.۸ حسابرسی (Audit)

۵.۹ تمرین کوتاه

۵.۱۰ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل ششم: منابع بشری و اداره

۶.۱ استخدام (Recruitment)

۶.۲ شرح وظایف (ToR)

۶.۳ لیست کوتاه (Shortlisting)

۶.۴ مصاحبه (Interview)

۶.۵ حاضری (Attendance)

۶.۶ رخصتی (Leave)

۶.۷ ارزیابی عملکرد (Performance)

۶.۸ اجرایات (Disciplinary Process)

۶.۹. محرمانه (Confidentiality)

۶.۱۰. حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی (PSEA)

۶.۱۱. تمرین کوتاه

۶.۱۲. خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل هفتم: هماهنگی و مدیریت Stakeholderها

۷.۱. Stakeholderها کی‌ها اند؟

۷.۲. هماهنگی با PPHD

۷.۳. هماهنگی با MoPH

۷.۴. هماهنگی با دفتر مرکزی

۷.۵. هماهنگی با جامعه

۷.۶. مدیریت تعارض (Conflict)

۷.۷. ارتباط (Communication)

۷.۸. تشدید (Escalation)

۷.۹. تمرین کوتاه

۷.۱۰. خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل هشتم: سناریوهای واقعی Provincial Coordinator

۸.۳۱. خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل نهم: Shuhada Organization را بشناس

۹.۱. تاریخچه

۹.۲. مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها

۹.۳. ساختار سازمانی

۹.۴. فعالیت‌های صحی SO در دایکندی

۹.۵. فرهنگ سازمانی SO

۹.۶. مسئولیت‌های این بست (Provincial Coordinator)

۹.۷. خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل دهم: شبیه‌سازی کامل امتحان و مصاحبه

آزمون آزمایشی ۱

آزمون آزمایشی ۲

آزمون آزمایشی ۳

۱۰.۱. خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

پایان کتاب — پیام آخر

پیوست ۱: واژه‌نامه دری-انگلیسی

پیوست ۲: قالب‌های کاری و چک‌لیست‌ها

۲.۱. چک‌لیست نظارت از یک مرکز صحت (Monitoring Visit)

۲.۲. قالب راپور ماهوار

۲.۳. قالب راپور حادثه‌ای (Incident Report)

۲.۴. کاربرد محاسبه AMC و Reorder Point

۲.۵. چک‌لیست تصفیه پیش‌پرداخت (Advance Clearance)

۲.۶. قالب پلان کاری ماهوار

۲.۷. قالب صورت‌جلسه کوتاه (Minutes)

پیوست ۳: پلان ۹۰ روزه اول کار

پیوست ۴: راهنمای امتحان و مصاحبه

پیوست ۵: منابع و مراجع

درباره این نسخه

پیشگفتار

پیش ببرد: هماهنگ‌کننده ولایتی (Provincial Coordinator) در بخش صحت. ریاست صحت عامه ولایت (PPHD) و مراکز صحتی می‌ایستد و باید کارها را به این کتاب برای کسی نوشته شده که در ولایت، میان دفتر مرکزی،

در آن لحظه بدانی اول چه کار کنی، بعد چه کار، و چطور همه‌اش را مستند کنی. نوشته شده است: نه برای اینکه «معلومات زیاد» به تو بدهد، بلکه برای اینکه است و سؤالی که تا ساعت ۱۲ جواب می‌خواهد. این کتاب برای همین لحظه‌ها نفرستاده، قابله‌ای که استعفا داده، بودجه‌ای که تمام شده، جلسه‌ای که امروز هر روز با چند نوع فشار روبه‌رو است: مریضی که دوا ندارد، کلینیکی که راپور با خواندن یک Job Description یاد گرفت. کسی که این کار را انجام می‌دهد، کار Coordinator را نمی‌توان فقط

این نسخه چه چیزی دارد؟

با Stakeholder ها و فرهنگ سازمانی Shuhada Organization می‌رسد. می‌شود و به نظام صحتی، تدارکات، مدیریت مالی، منابع بشری، هماهنگی • ده فصل که از ذهن و روش کار Coordinator شروع

هر فصل: «تمرین کوتاه» با سناریو و جواب مدل - به زبان دری و انگلیسی. • بخش دوم

واقعی کار Coordinator، هر یک با خط اقدام و جواب انگلیسی برای مصاحبه. • فصل هشتم: سی سناریوی

آزمایشی کامل (چند گزینه‌ای، سؤال کوتاه، سناریو، محاسبه و راپورنویسی). • فصل دهم: سه آزمون

کنی، پلان ۹۰ روزه اول کار، راهنمای مصاحبه، و واژه‌نامه دری-انگلیسی. • پیوست‌ها: قالب‌های کاری که می‌توانی همان روز در دفتر استفاده

• یک اصل در تمام کتاب تکرار می‌شود: بفهم ← بررسی کن ← اولویت بده ← اقدام کن ← مستند کن ← راپور بده ← پیگیری کن.

درباره صحت معلومات این نسخه

سازمان جهانی صحت و شرکای صحتی افغانستان. منابع در پیوست ۵ یاد شده‌اند. صحت عامه، اصول شش‌گانه IASC در مورد PSEA، و معلومات صحت عامه بسته خدمات صحتی اساسی (BPHS) وزارت صحت عامه، راهنمای HMIS وزارت که ممکن بوده، با منابع معتبر مقایسه و تصحیح شده است - از جمله معیارهای معلومات صحتی و اداری این کتاب، جایی

یادآوری مهم: این کتاب یک‌راهنمای آموزشی و کاری یا دفتر مرکزی بررسی. است. جایی که کتاب جواب قطعی ندارد، همان‌جا می‌گوید که باید از PPHD وزارت صحت عامه (MoPH)، پالیسی سازمان خودت و راهنمای PPHD ولایت که به مریض، دوا یا درمان مربوط می‌شود، معیار نهایی همان راهنمای رسمی است، نه سند پالیسی و نه پروتوکول درمانی. در هر موردی

درباره این کتاب

در ولایت دایکندی و ساختار رسمی نظام صحت افغانستان تهیه شده است. بخش صحت است. محتوای آن بر اساس وظایف واقعی این بست، تجربه میدانی عملی و خودآموز برای هماهنگ‌کنندگان ولایتی (Provincial Coordinator) در این کتاب یک راهنمای

این کتاب برای کیست؟

Provincial گماشته شده و باید در چند هفته اول کار را راه بیندازد. ۱. کسی که تازه به بست Coordinator

اما می‌خواهد روش کار خود را یکدست کند و راپور و پیگیری خود را قوی‌تر بسازد. ۲. کسی که چند سال Coordinator بوده،

۳. کسی که برای امتحان و مصاحبه این بست آماده می‌شود.

و مالی که با Coordinator کار می‌کنند و باید بدانند از آن‌ها چه انتظاری می‌رود. ۴. کارمندان صحتی، HMIS، تدارکات

در این نسخه چه چیز اصلاح و اضافه شده است؟

Health Post، BHC، و شفاخانه‌ها) با معیار رسمی BPHS تصحیح شد.

• معیارهای جمعیتی مراکز صحتی (CHC)

راپوردهی HMIS و اصول PSEA با منابع معتبر مقایسه و اصلاح شد.

• ساختار وزارت صحت عامه، مهلت‌های

چطور خدمات اساسی تأمین می‌شود و این برای Coordinator چه معنی دارد.

• بخش جدید ۳.۸ اضافه شد: نظام صحتی افغانستان امروز (۱۴۰۵) -

• به شروع هر فصل یک بخش «اهداف این فصل» اضافه شد.

پلان ۹۰ روزه، راهنمای مصاحبه) و واژه‌نامه دری-انگلیسی اضافه شد.

• پیوست‌های کاری (قالب‌ها،

همه‌جا یکسان به کار رفته و نیم‌فاصله، نقطه‌گذاری و اعداد نظم گرفته است.

شد: اصطلاحات افغانی (مریض، شفاخانه، ولسوالی، ماهوار، ربعوار) در

• زبان کتاب یکدست‌سازی

چگونه از این کتاب استفاده کنیم

۱. اگر وقت کم داری (۱۰ روز): آزمون آزمایشی فصل دهم را با وقت‌گیری حل کن. فصل را بازگو کن. روز نهم فصل هشتم (سناریوها) را دوره کن و روز دهم یک روز یک فصل بخوان و همان شب «تمرین کوتاه» و «جواب‌های طلایی» همان هر

۲. اگر برای کار روزمره می‌خوانی (۴ هفته): یک پلان کاری یا راپور واقعی بنویس. ۶ و ۷؛ هفته چهارم فصل‌های ۸ تا ۱۰. هر فصل را با یک کار عملی تمام کن: هفته اول فصل‌های ۱ تا ۳؛ هفته دوم فصل‌های ۴ و ۵؛ هفته سوم فصل‌های

۳. اگر برای مصاحبه آماده می‌شوی (۳ روز): ۸ و یک آزمون آزمایشی فصل ۱۰. فصل‌های ۳ تا ۷ (نظام صحی، تدارکات، مالی، HR، هماهنگی)؛ روز سوم فصل روز اول فصل‌های ۱، ۲ و ۹ (ذهن کار، راپورنویسی، شناخت سازمان)؛ روز دوم

نشانه‌های کتاب

نشانه	معنی
★ برای امتحان	در امتحان و مصاحبه بیشترین استفاده را دارد جمله‌ای که
● حفظ کن	قاعده‌ای که باید از حفظ بدانی
✓ / ✗	اشتباه رایج و شکل درست آن
مفهوم ساده	تعریف کوتاه و ساده مفهوم
مثال از دایکندی	کاربرد همان مفهوم در وضعیت واقعی ولایت
جواب مدل	جواب نمونه دری برای سناریوی تمرین
Sample Answer	به انگلیسی – برای مصاحبه و امتحان نوشتاری همان جواب

نقشه راه ده فصل

فصل	موضوع	خروجی عملی برای تو	برای امتحان
۱	KPI، اولویت‌بندی وظایف، پلان، نظارت، یک Coordinator: ذهن	ماهوار نوشته‌شده یک پلان کاری	بسیار مهم
۲	و ارتباطات حرفه‌ای راپورنویسی	و یک خلاصه اجرایی یک راپور ماهوار	بسیار مهم
۳	DHIS2 و MoPH، PPHD، BPHS/EPHS، HMIS نظام صحتی:	از ثبت معلومات یک چک‌لیست نظارت	بسیار مهم
۴	لوژستیک و دارایی‌ها تدارکات، دوا،	Reorder مرکز خودت محاسبه AMC و Point	مهم
۵	Variance، Advance، مالی: بودجه، Audit، مدیریت	پیش‌پرداخت کامل یک تصفیه	مهم
۶	اجرایات، PSEA، استخدام، حاضری، منابع بشری و اداره:	پلان پیگیری حاضری یک ToR و یک	مهم
۷	Stakeholderها هماهنگی و مدیریت	ولایت خودت Stakeholderهای فهرست	متوسط
۸	واقعی با جواب مدل سی سناریوی	اقدام برای هر سناریو خط	بسیار مهم
۹	Shuhada Organization را بشناس	مأموریت و ارزش‌ها آماده در باره جواب‌های	مهم
۱۰	آزمایشی و مصاحبه سه آزمون	نمره آزمون خودت	تمرینی

فهرست اختصارات

رفته است. در مصاحبه، اگر اختصاری را کامل بگویید، امتیاز بیشتری می‌گیری. این اختصارات در سراسر کتاب به کار

اختصار	به انگلیسی	به دری
ANC	Antenatal Care	از ولادت (معاینه زن باردار) مراقبت پیش
AMC	Average Monthly Consumption	مصرف متوسط ماهوار
BHC	Basic Health Center	مرکز صحتی اساسی
BPHS	Basic Package of Health Services	بسته خدمات صحتی اساسی
CHC	Comprehensive Health Center	مرکز صحتی جامع
CHW	Community Health Worker	کارمند صحتی جامعه (صحیار)
DH	District Hospital	شفاخانه ولسوالی
DHIS2	District Health Information Software 2	معلومات صحتی دیجیتال سیستم
EPHS	Essential Package of Hospital Services	خدمات اساسی شفاخانه‌ای بسته
EPI	Expanded Program on Immunization	برنامه گسترده واکسیناسیون
HMIS	Health Management Information System	معلومات مدیریت صحتی سیستم
HP	Health Post	خانه صحتی (پست صحتی)
HR	Human Resources	منابع بشری
IASC	Inter-Agency Standing Committee	کمیته دایمی بین‌الوکاله‌ای
KPI	Key Performance Indicator	شاخص کلیدی عملکرد
MHT	Mobile Health Team	تیم صحتی سیار

اختصار	به انگلیسی	به دری
MoPH	Ministry of Public Health	وزارت صحت عامه
NGO	Non-Governmental Organization	سازمان غیردولتی
OPD	Out-Patient Department	بخش سرپایی
PNC	Postnatal Care	مراقبت بعد از ولادت
PHC	Primary Health Care	خدمات صحت اولیه
PPHCC	Provincial Public Health Coordination Committee	کمیته هماهنگی صحت ولایت
PPHD	Provincial Public Health Directorate	ریاست صحت عامه ولایت
PSEA	Protection from Sexual Exploitation and Abuse	استثمار و سوء استفاده جنسی حفاظت از
SHC	Sub Health Center	مرکز صحت فرعی
SO	Shuhada Organization	سازمان شهدا
TB	Tuberculosis	سل
ToR	Terms of Reference	شرح وظایف
UNICEF	United Nations Children's Fund	حمایت از اطفال ملل متحد صندوق
WHO	World Health Organization	سازمان جهانی صحت

بسم الله الرحمن الرحيم

راهنمای جامع و عملی Provincial Coordinator

Shuhada Organization – Daikundi

شهدا سازمان - ولایت دایکندی

«Working for a better tomorrow»

درباره این کتاب

می‌باشد. این نسخه، نسخه اصلاح‌شده، یک‌دست‌سازی‌شده و آماده نشر است. عملی، سه امتحان آزمایشی کامل و پاسخ‌های نمونه به زبان دری و انگلیسی

ساختار رسمی نظام صحتی افغانستان تهیه شده و شامل ده فصل، سی سناریوی محتوای آن بر اساس وظایف واقعی این بست، تجربه میدانی در ولایت دایکندی و برای هماهنگ‌کنندگان ولایتی (Provincial Coordinator) در بخش صحت است. این کتاب یک راهنمای عملی و خودآموز

نسخه اصلاح‌شده و آماده نشر

۱۴۰۵ خورشیدی

فهرست مطالب

Provincial چگونه کار می‌کند؟

فصل اول: ذهن یک Provincial Coordinator

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. وظایف واقعی یک Provincial Coordinator را فهرست می‌کنی و می‌دانی کجا Coordinator است و کجا نه.
۲. می‌توانی یک پلان کاری واضح، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی‌شده بنویسی.
۳. Monitoring و Risk، Evaluation و Issue، و اولویت‌بندی کارها را توضیح می‌دهی.
۴. چرخه هفت‌مرحله‌ای کار Coordinator را در یک وضعیت واقعی به کار می‌بری.

۱.۱ وظایف واقعی یک Provincial Coordinator

مفهوم ساده

اما کارت در تمام ولسوالی‌ها، کلینیک‌ها و شفاخانه‌هاست Provincial Coordinator. یعنی «هماهنگ‌کننده ولایتی». تو در مرکز ولایت می‌نشینی،

تو مدیر کل نیستی - تو حلقه وصل هستی:

- بین دفتر مرکزی (Central Office) و مراکز صحتی ولایت
- بین ریاست صحت عامه ولایت (PPHD) و سازمان خودت
- بین کارمندان صحتی، مالی، تدارکات و منابع بشری
- بین جامعه (مردم، قریه، شورای صحتی) و خدمات صحتی

افغان با تمرکز بر توانمندسازی زنان و اطفال است (SO) Shuhada Organization (SO) غیرانتفاعی، غیرسیاسی و مستقل است و هدف اصلی‌اش رفاه و پیشرفت شهروندان برای زنان و اطفال افغان پناهنده در کویت، پاکستان بود. این سازمان غیردولتی، در سال ۱۹۸۹ توسط دکتر سیما سمر بنیان گذاشته شد؛ اولین مرکز آن شفاخانه‌ای و در ولایات مرکزی افغانستان - از جمله دایکندی، بامیان و غزنی - کار می‌کند SO بخش‌های صحت، آموزش، حقوق بشر و توانمندسازی اقتصادی زنان فعالیت دارد.

ارزش‌های SO را حفظ کن

(Gender Sensitivity) • حرفه‌ای بودن (Professionalism) • تعالی (Excellence) • شفافیت (Transparency) • پاسخگویی (Accountability) • حساسیت جنسیتی

وظایف عمده‌ای که در Job Description آمده است

وظیفه	یعنی چه؟
نظارت بر تطبیق پلان کاری	کردن اینکه کارها طبق پلان پیش می‌رود چک
هماهنگی با PPHD	رفتن به جلسات، شریک کردن راپور، پیگیری
نظارت (Monitoring) از مراکز صحت	رفتن به ساحه، دیدن، پرسیدن، ثبت کردن
مدیریت راپور HMIS	چک کردن و فرستادن معلومات صحت جمع‌آوری،
پیگیری تدارکات و مالی	از اینکه دوا، تجهیزات و پول به موقع می‌رسد اطمینان
مدیریت منابع بشری	حاضری، اجراات، رفع مشکلات کارمندان استخدام،
راپوردهی به دفتر مرکزی	ربعوار، و در صورت ضرورت راپور حادثه‌ای راپور ماهوار،

مثال از دایکندی

(BHC) دوا تمام کرده. مسئول کلینیک تماس می‌گیرد. تو باید همزمان چند کار بکنی:
فرض کن در ولسوالی شهرستان دایکندی یک (Basic Health Center)

- پیگیری با تدارکات - دوا از کجا بیاید؟
- اطلاع دادن به PPHD - شاید از ذخیره ولایتی کمک شود
- Stock Card - چرا دوا تمام شده؟ مصرف زیاد بوده یا تدارکات دیر رسیده؟
- چک
- راپور دادن به دفتر مرکزی - اگر مشکل بزرگ است، باید بدانند
- پیگیری تا رسیدن دوا - نه فقط یک بار تماس گرفتن

برای امتحان

پیگیری دارد. اگر فقط مشکل را شنید و اقدام نکرد، کار نکرده است Coordinator فقط «هماهنگ‌کننده» نیست؛ مسئولیت

پلان‌سازی – ۱.۲ Planning

مفهوم ساده

که چه کار، کی، چطور، با کدام منبع و از کجا پول آن تأمین می‌شود Planning یعنی: قبل از اینکه کار شروع شود، بنویس در محیط صحنه افغانستان، پلان‌سازی سه سطح دارد:

مثال	کی می‌سازد؟	سطح
پلان پنج‌ساله BPHS	دفتر مرکزی + MoPH	پلان استراتژیک
پلان صحنه سالانه ولایت	دفتر مرکزی + PPHD	پلان سالانه
نظارت، تدارکات، جلسات پلان	تو – Coordinator	پلان کاری ماهوار/ربعوار

مثال از دایکندی

پلان کاری ماهوار تو ممکن است این طور باشد:

هفته	فعالیت	مسئول	ساحه/وسیله	تاریخ
۱	از BHC نیلی نظارت	Coordinator	نیلی / موتر	هفته اول
۲	جلسه PHCC	Coordinator + PPHD	مرکز ولایت	هفته دوم
۳	کردن Stock چک	تدارکات	تمام مراکز	هفته سوم
۴	راپور HMIS جمع آوری	HMIS Officer	کمپیوتر / دفتر ولایتی	هفته چهارم

حفظ کن

کاری باید ۵ چیز داشته باشد: چه کار؟ کی؟ کجا؟ با کدام منبع؟ چگونه چک می شود؟
هر پلان

پلان کاری - Work Plan ۱.۳

مفهوم ساده

چه بشود Planning است. فرقی این است که Planning نسخه عملی Work Plan می‌گوید «چه کسی، کی، چطور انجام می‌دهد Work Plan»، «می‌گوید» باید

خوب این‌طور است Work Plan

از BHC «کافی نیست؛ بنویس «نظارت از BHC نیلی - چک کردن ۱۰ شاخص».

- واضح: «نظارت

- «بهبود کیفیت» کافی نیست؛ بنویس «افزایش استفاده از ANC از ۳۰٪ به ۵۰٪».
- قابل اندازه‌گیری:

مشخص: «تیم» کافی نیست؛ بنویس «مسئول HMIS ولایتی + Coordinator».

- مسئول

- زمان مشخص: «بعداً» کافی نیست؛ بنویس «تا ۱۵ ماه جاری».

مثال از دایکندی

اشتباهات رایج

۰۸ پلان ضعیف

«در ماه جاری از کلینیک‌های دایکندی نظارت می‌کنیم.»

اشتباهات رایج

۰۷ پلان قوی

Coordinator + PPHD و دفتر مرکزی فرستاده می‌شود. «
معلومات HMIS، موجودی دوا و حاضری کارمندان است. مسئول: HMIS Officer
نیلی، اشتراکی و شهرستان نظارت می‌کنیم. تمرکز نظارت روی ثبت صحیح
«تا ۲۵ ماه جاری، از ۵ BHC در ولسوالی‌های

۱.۴ نظارت (Monitoring) - چطور و چرا؟

مفهوم ساده

Monitoring. یعنی رفتن، دیدن، پرسیدن، ثبت کردن و پیگیری کردن Monitoring نیست (Evaluation) ارزیابی

	Monitoring	Evaluation
کی؟	در جریان کار	بعد از تمام شدن
چرا؟	آیا طبق پلان پیش می‌رویم؟	آیا به هدف رسیدیم؟
کی می‌کند؟	Coordinator، PPHD	تیم ارزیابی، دوتر
مثال	چک کردن Stock Card	کاهش مرگ‌ومیر مادران بررسی

مثال از دایکندی

تو به یک BHC در نیلی می‌روی. چه چک می‌کنی؟

- آیا ثبت‌ها کامل است؟ - Register
- آیا دوا موجود است؟ تاریخ انقضا چک شده؟ - Stock Card
- حاضری - آیا کارمندان حاضر اند؟
- راپور - آیا ماه گذشته راپور فرستاده شده؟ HMIS
- مریضان - چند مریض امروز آمده؟ آیا خدمات اساسی ارائه شده؟
- زمینه - آیا کلینیک تمیز است؟ تجهیزات کار می‌کند؟

برای امتحان

بگویی و در راپور بنویسی. اگر ننویسی، انگار نرفته‌ای Feedback بدون Monitoring فایده ندارد. اگر مشکل دیدی، باید به مسئول کلینیک

Sample Answer

During a monitoring visit, I check the registers, stock cards, attendance, and HMIS reports. I compare reported data with source documents, identify gaps, discuss with the facility staff, provide on-the-job feedback, and document findings. I then follow up to ensure corrective actions are taken.

۱.۵ شاخص کلیدی عملکرد (KPI)

مفهوم ساده

نتوانی اندازه بگیری، نمی‌توانی مدیریت کنی (KPI (Key Performance Indicator یعنی معیاری که موفقیت را نشان می‌دهد. اگر

KPI	یعنی چه؟	مثال از دایکندی
ANC Coverage	باردار برای معاینه آمده‌اند چند زن	۴۰۰ زن در ولسوالی نیلی
Skilled Birth Attendance	با داکتر/قابل انجام شده چند ولادت	۱۵۰ از ۲۰۰ ولادت
HMIS Reporting Rate	فیصد مراکز راپور فرستاده‌اند چند	۹۵٪ - یعنی ۵٪ دیر کرده
Drug Availability	چند فیصد دوا موجود است	۸۰٪ - ۲۰٪ کمبود
Stock-out Days	چند روز دوا نبوده	۵ روز - مشکل دارد

مثال از دایکندی

راپور نفرستاده‌اند. سؤال Coordinator فقط «چند فیصد؟» نیست؛ باید بررسی می‌گیری: «HMIS Reporting Rate در ولایت ۷۰٪ است.» این یعنی ۳۰٪ کلینیک‌ها تو راپور

- کدام کلینیک‌ها نفرستاده‌اند؟
- چرا؟ مشکل تکنیکی؟ نبود کارمند؟ مشکل امنیتی؟
- چه اقدام فوری لازم است؟
- مسئول کیست؟ کی پیگیری می‌شود؟

حفظ کن

اگر KPI فقط یک عدد باشد و اقدام نداشته باشد، آن KPI نیست - یک آمار است. هر KPI باید قابل اندازه‌گیری، قابل مقایسه و قابل اقدام باشد.

فرق‌شان چیست؟ - Risk و Issue ۱.۶

Issue (مشکل)	Risk (خطر)	
چیزی که قبلاً اتفاق افتاده	که ممکن است اتفاق بیفتد چیزی	چیست؟
حال	آینده	کی؟
«راه نیلی بسته است»	زمستان راه نیلی را ببندد» «ممکن است	مثال
حل کردن	پیشگیری	اقدام

مثال از دایکندی

Issue	Risk
دوا در BHC شهرستان تمام شده	ممکن است دوا در زمستان دیر برسد
یک قابله در نیلی استعفا داده	ممکن است یک کارمند استعفا بدهد
راپور ماه گذشته فرستاده نشده	ممکن است راپور HMIS دیر شود

کار Coordinator:

• Risk ← پلان پیشگیری بساز (مثلاً: دوا را قبل از زمستان برسان)

• Issue ← فوراً حل کن، بعد راپور بده

Sample Answer

A risk is a potential future problem that may or may not happen. An issue is a problem that has already occurred. As a coordinator, I manage risks by planning mitigation measures in advance, and I manage issues by taking immediate corrective action, documenting it, and reporting to the relevant stakeholders.

کدام کار اول؟ – ۱.۷ Prioritization

مفهوم ساده

کارها را همزمان انجام بدهی. Prioritization یعنی انتخاب کردن مهم‌ترین کار. تو نمی‌توانی همه

اولویت	نوع کار	مثال
۱ - فوری	زندگی مردم در خطر	- جان مریض در خطر است نبود دوا در کلینیک
۲ - مهم	خدمات اساسی متوقف شود	- ولادت انجام نمی‌شود نبود قابله
۳ - ضروری	راپور و هماهنگی	راپور ماهوار دیر شود
۴ - معمولی	جلسات، فایلینگ	جلسه PHCC

مثال از دایکندی

یک روز صبح سه مشکل داری:

- در BHC نیلی دوا تمام شده - مریضان برمی‌گردند
 - راپور HMIS ماه گذشته هنوز فرستاده نشده - امروز آخرین روز است
 - جلسه هماهنگی با PPHD ساعت ۱۰ است
- و خودت نظارت کنی. جلسه را هم می‌توانی با یک همکار بفرستی یا بعداً بروی. در خطر است. راپور HMIS هم مهم است، اما می‌توانی به HMIS Officer بسپاری کدام اول؟ مشکل دوا - چون زندگی مردم

برای امتحان

زندگی کسی در خطر است یا خدمات اساسی متوقف شده. اگر بله، فوراً اقدام کن. در سناریو امتحان، اولین کارت همیشه این باشد: چک کن آیا

پیگیری - ۱.۸ Follow-up

مفهوم ساده

مشکل را که شنیدی، حلش کن - بعد هم چک کن که واقعاً حل شده Follow-up یعنی رها نکردن.

به روز نیست. به مسئول گفتی: «تا هفته آینده اصلاح کن.» Follow-up یعنی: تو به BHC اشتراک رسانی و دیدی Stock Card

- هفته آینده تماس بگیری یا بروی
- چک کنی که اصلاح شده یا نه
- اگر نشده، بررسی چرا
- اگر باز هم نشد، به PPHD یا دفتر مرکزی اطلاع بدهی
- در راپور بنویسی که پیگیری انجام شده

حفظ کن

Verify → Act → Document → بررسی | Follow Up → اقدام ← مستندسازی
← پیگیری - این چهار کلمه را در هر سناریو امتحان به کار ببر.

۱.۹ چرخه کار Coordinator - از اول تا آخر

بفهم (Understand)

بررسی کن (Verify)

اولویت بده (Prioritize)

اقدام کن (Act)

مستند کن (Document)

راپور بده (Report)

پیگیری کن (Follow Up)

دوباره بررسی کن (Re-verify)

مثال کامل از دایکندی

تعداد مریضان TB صفر ثبت شده - در حالی که سال گذشته ۱۵ مریض بود. موقعیت: راپور HMIS نشان می‌دهد که در BHC نیلی،

بفهم: چرا صفر؟ آیا واقعاً مریض نیست، یا ثبت نمی‌شود؟

مراجعه کن، با مسئول TB صحبت کن، ببین آیا مریضان به جای دیگر می‌روند. بررسی کن: به Register کلینیک

ثبت نمی‌شود، مریضان TB از خدمات محروم می‌شوند - این اولویت اول است. اولویت بده: اگر

بگو ثبت را اصلاح کند؛ اگر لازم است آموزش کوتاه بده؛ به PPHD اطلاع بده. اقدام کن: به مسئول کلینیک

کن: در راپور نظارت بنویس - تاریخ، کلینیک، مشکل، اقدام، مسئول پیگیری. مستند

راپور بده: راپور را به دفتر مرکزی و PPHD بفرست.

پیگیری کن: هفته بعد چک کن که ثبت TB درست شده یا نه.

Sample Answer

First, I would verify the data against the TB register at the facility. Then I would discuss with the TB focal point to understand whether there is a recording issue or if patients are seeking care elsewhere. If it is a recording issue, I would provide on-the-job feedback, ensure corrective action is taken, document the findings, report to PPHD, and follow up to confirm the data is accurate in the next reporting period.

۱.۱۰ اشتباهات رایج یک Coordinator

اشتباهات رایج

- ❖ اشتباه ۱: فقط مشکل را شنیدن و کاری نکردن.
- ❖ درست: هر مشکل باید اقدام، مسئول و زمان پیگیری داشته باشد.

اشتباهات رایج

- ❖ اشتباه ۲: همه کارها را خودت انجام دادن.
- ❖ درست: Coordinator کار تیم را هماهنگ می‌کند، خودش همه کار نمی‌کند.

اشتباهات رایج

- ❖ اشتباه ۳: راپور را دیر فرستادن.
- ❖ درست: راپور به موقع = اعتماد PPHD و دفتر مرکزی.

اشتباهات رایج

- ❖ اشتباه ۴: قبول کردن معلومات بدون چک کردن.
- ❖ درست: همیشه با منبع اصلی (Register, Stock Card, حاضری) مقایسه کن.

اشتباهات رایج

- ❖ اشتباه ۵: در جلسه PPHD خاموش نشستن.
- ❖ درست: مشکل را واضح بگو، اقدام پیشنهاد کن، پیگیری بخواه.

۱.۱۱ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه

باید تا ساعت ۱۲ جواب بدهی. سؤال: تو چه می‌کنی؟ به کدام اولویت می‌دهی؟ چرا؟ آخرین روز فرستادن به PPHD است. (۳) دفتر مرکزی یک سؤال مالی فوری دارد که HMIS: راپور ماه گذشته ولایت ناقص است - ۱۰ کلینیک راپور نفرستاده‌اند و امروز Paracetamol و Amoxicillin تمام شده و ۲۰ مریض در صف است. (۲) Officer دایکندی هستی. ساعت ۸ صبح سه خبر می‌رسد: (۱) BHC نیلی: دواي اساسی (مثلاً) تو Coordinator ولایت

جواب مدل

و اگر نرسیدم، به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم که تا چند ساعت دیگر می‌فرستم. - خودم نظارت می‌کنم. جواب مالی را در وقت باقی‌مانده تا ساعت ۱۲ آماده می‌کنم HMIS Officer را مسئول می‌کنم که با ۱۰ کلینیک تماس بگیرد و راپور را جمع کند از PPHD کمک می‌خواهم و اگر ممکن باشد دوا را از مرکز نزدیک‌تر می‌فرستم. بعد در صف هستند و زندگی‌شان در خطر است. فوراً با تدارکات ولایتی تماس می‌گیرم، اول مشکل دوا را حل می‌کنم - چون مریضان

Sample Answer

First, I would prioritize the medicine stock-out because patient lives are at risk. I would immediately contact the provincial logistics team, request support from PPHD, and arrange emergency supply from the nearest facility if possible. Second, I would assign the HMIS Officer to follow up with the 10 facilities that have not submitted reports, while I monitor progress. Third, I would address the finance query from the central office within the deadline, and if I cannot meet it, I would communicate a realistic timeline. Throughout, I would document all actions and follow up.

۱.۱۲ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

فصل اول در شش جمله:

- کلینیک‌ها و جامعه، PPHD، حلقه وصل بین دفتر مرکزی = Coordinator

- چه کار، کی، کجا، چطور، با کدام منبع = Work Plan
- Monitoring = رفتن، دیدن، پرسیدن، ثبت کردن، پیگیری کردن
- KPI = نیست KPI، معیار موفقیت؛ اگر اقدام نداشته باشد = KPI
- Risk = قبلاً اتفاق افتاده = Issue ممکن است اتفاق بیفتد؛ = Risk
- Prioritization = زندگی مردم، بعد خدمات اساسی، بعد راپور، بعد جلسات اول.

← مستند کن ← اقدام کن ← اولویت بده ← بررسی کن ← هفت کلمه طلایی: بفهم
پیگیری کن ← راپور بده

جواب‌های طلایی فصل اول

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
اصلی Coordinator چیست؟ وظیفه	– نه انجام همه کارها نظارت، پیگیری و راپوردهی هماهنگی،	Coordinate, monitor, follow up, and report – not doing everything alone.
مطابقت نداشته باشد؟ اگر معلومات با Register	کن، اصلاح کن، پیگیری کن کن، با مسئول صحبت چک کن، تفاوت را مشخص با منبع اصلی	Verify against source documents, identify the discrepancy, discuss with staff, correct it, and follow up.
اولویت اول در کار چیست؟	مردم و تداوم خدمات اساسی زندگی	Patient safety and continuity of essential health services.
Monitoring با Evaluation چه فرق دارد؟	جریان کار است؛ Monitoring از تمام شدن Evaluation در بعد	Monitoring is during implementation; evaluation is after completion.

A risk may happen; an issue has already happened.	ممکن است اتفاق بیفتد؛ Risk قبلاً اتفاق افتاده Issue	چه فرق دارد؟ Risk با Issue
Find the cause, submit immediately, inform the central office, and prevent recurrence.	بده، از تکرار جلوگیری کن بفرست، به دفتر مرکزی اطلاع علت را پیدا کن، فوراً	اگر راپور دیر شود چه می‌کنی؟

نکته آخر فصل اول

اگر فکر کنی، اولویت بدهی، اقدام کنی و پیگیری کنی Provincial Coordinator می‌گیرد و پیگیری می‌کند. اگر فقط معلومات جمع کنی و بفرستی، منشی هستی؛ هستی Coordinator – کسی است که فکر می‌کند، تصمیم

فصل دوم: راپورنویسی و ارتباطات حرفه‌ای

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. یک راپور ماهوار واقعی را با ساختار کامل (مقدمه، فعالیت‌ها، نتایج، مشکلات، درس‌ها، پلان آینده) می‌نویسی.
۲. خلاصه اجرائی نیم‌صفحه‌ای می‌نویسی که نتیجه را پیش از توضیح می‌گوید.
۳. برای هر مشکل یک پلان اقدام (مشکل، اقدام، مسئول، زمان، شاخص) می‌سازی.
۴. راپور حادثه‌ای را همان روز آماده می‌کنی.

مهم‌ترین مهارت یک Coordinator

راپور ضعیف = مشکل. راپور خوب سه چیز دارد: واضح، مختصر، قابل اقدام. PPHD، دفتر مرکزی و دونر همه از تو راپور می‌خواهند. راپور خوب = اعتماد؛ اگر فقط یک مهارت را در این کتاب یاد بگیری، همین باشد: راپورنویسی. چون

۲.۱ راپورنویسی (Reporting) – چرا این قدر مهم است؟

مفهوم ساده

بفهمد چه کار کردی، چه نتیجه‌ای گرفتی، چه مشکلی داری و چه می‌خواهی. راپور یعنی نوشتن آنچه اتفاق افتاده - به شکلی که خواننده راپور خوب:

- واضح: خواننده در یک بار خواندن بفهمد
 - مختصر: کوتاه، بدون کلمات اضافی
 - قابل اقدام: هر مشکل - راه‌حل، مسئول و زمان دارد
 - صادق: نه بزرگ‌نمایی، نه پنهان‌کاری
- راپور ضعیف:
- طولانی و پر از کلمات تکراری
 - مشکل را می‌گوید، اما راه‌حل ندارد
 - آمار می‌دهد، اما تحلیل ندارد
 - «همه کارها خوب پیش می‌رود» - بدون معلومات واقعی

اشتباهات رایج

۴۰ راپور ضعیف

همه چیز خوب بود. بعضی مشکلات کوچک وجود داشت که انشاءالله حل می‌شود. «در ماه جاری از کلینیک‌ها نظارت کردیم.»

اشتباهات رایج

۷۰ راپور قوی

Coordinator. زمان: تا ۱۵ ماه آینده. راپور پیگیری در ماه بعد ارائه می‌شود. «به ۴ مسئول کلینیک هدایت داده شد تا Stock Card را اصلاح کنند. مسئول پیگیری: Stock Card به‌روز نداشتند. علت: نبود کارمند مسئول تدارکات در ۲ کلینیک. اقدام: ۵ BHC در ولسوالی‌های نیلی، اشتروی و شهرستان نظارت کردیم. نتیجه: ۴ کلینیک «در ماه جاری از

۲.۲ راپور روایتی (Narrative Report)

مفهوم ساده

توضیح می‌دهی چه کار کردی، چرا، چطور و چه نتیجه‌ای گرفتی Narrative Report
 راپوری که به شکل داستان/روایت نوشته می‌شود - نه فقط جدول و آمار. در آن
 یعنی.

بخش	چه بنویسی؟
۱. مقدمه (Introduction)	است؟ کدام ولایت؟ کدام فعالیت‌ها؟ این راپور برای چه دوره‌ای
۲. فعالیت‌های انجام‌شده	چه کار کردی؟ کجا؟ با کی؟
۳. نتایج (Results)	چه نتیجه‌ای گرفتی؟ آمار و ارقام
۴. مشکلات (Challenges)	چه مشکلی داشتی؟ چرا؟
۵. درس‌ها (Lessons Learned)	چه یاد گرفتی؟ دفعه بعد چه کنی؟
۶. پلان آینده (Way Forward)	ماه/ربع بعد چه کار می‌کنی؟

مثال از دایکندی - راپور ماهوار، ماه حمل ۱۴۰۵

این راپور فعالیت‌های صحتی ولایت دایکندی را در ماه حمل ۱۴۰۵ پوشش می‌دهد.
• مقدمه:

جمع‌آوری راپور HMIS از ۲۰ کلینیک؛ پیگیری تدارکات دوا برای ۳ کلینیک. ولسوالی‌های نیلی، اشتدرلی و شهرستان؛ ۲ جلسه هماهنگی با PPHD دایکندی؛
• فعالیت‌ها: نظارت از ۵ BHC در

• ۳) Drug Availability: ۸۵٪ کلینیک کمبود دوا) • Attendance Rate: ۹۰٪
• نتایج: ۱۹) HMIS Reporting Rate: ۹۵٪ از ۲۰ کلینیک)

دوا در BHC شهرستان در ۵ روز اول ماه تمام بود - علت: تأخیر در تدارکات. کلینیک در ولسوالی اشتدرلی راپور HMIS نفرستاده - علت: نبود کارمند HMIS؛
• مشکلات: یک

به آموزش کارمندان موجود؛ برنامه‌ریزی تدارکات باید قبل از زمستان انجام شود. کمبود کارمند HMIS در ولسوالی‌های دور باعث تأخیر راپور می‌شود - نیاز
• درس‌ها:

تدارکات دوا برای BHC شهرستان تا ۱۰ ثور؛ نظارت از ۵ BHC دیگر در ماه ثور.
• پلان آینده: آموزش HMIS برای ۲ کارمند در اشتدرلی تا ۱۵ ثور؛ پیگیری

برای امتحان

Introduction: را حفظ نکن - ساختارش را حفظ کن Narrative Report
Way Forward. ← Lessons ← Challenges ← Results ← Activities

۲.۳ راپور ماهوار و ربعوار (Monthly/Quarterly Report)

راپور ربعوار	راپور ماهوار	
دوره	هر ماه	هر ۳ ماه
طول	۱-۲ صفحه	۳-۵ صفحه
جزئیات	خلاصه فعالیت‌ها	تحلیل عمیق‌تر، روند (Trend)
برای کی؟	دفتر مرکزی، PPHD	دفتر مرکزی، دونر

چکلیست راپور ماهوار خوب

اشتباهات رایج

- ✓ فعالیت‌های اصلی ماه (۳-۵ مورد) ✓ آمار کلیدی (KPIها)
- ✓ مشکلات فوری ✓ اقدامات انجام‌شده

اشتباهات رایج

- ✓ پلان ماه بعد ✓ ضمیمه: راپور HMIS (اگر جدا فرستاده نمی‌شود)

چکلیست راپور ربعوار خوب

اشتباهات رایج

- ✓ خلاصه اجرایی (Executive Summary) ✓ مقایسه با ربع قبل (Trend)
- ✓ تحلیل مشکلات - نه فقط لیست ✓ درس‌های آموخته‌شده ✓ پلان ربع بعد

مثال از دایکندی - خلاصه بخش مقایسه ربع اول ۱۴۰۵

در ربع قبل به ۹۵٪ افزایش یافت. مشکل اصلی: کمبود دوا در ۳ کلینیک دورافتاده. نمود و ۳ جلسه هماهنگی با PPHD برگزار کرد. HMIS Reporting Rate از ۸۵٪ ولایت دایکندی از ۱۲ BHC نظارت کرد، راپور ۲۰ HMIS کلینیک را جمع‌آوری خلاصه اجرائی: در ربع اول ۱۴۰۵، Coordinator

شاخص	ربع قبل	ربع جاری	تغییر
Reporting Rate	۸۵٪	۹۵٪	+۱۰٪
Drug Availability	۹۰٪	۸۵٪	-۵٪
Supervision Visits	۱۰	۱۲	+۲

مؤثر بوده. کاهش Drug Availability به دلیل تأخیر تدارکات زمستانی است. تحلیل: افزایش Reporting Rate نشان می‌دهد که پیگیری‌های Coordinator درس‌ها: برنامه‌ریزی تدارکات باید ۲ ماه قبل از زمستان شروع شود. بعد: نظارت از ۱۲ BHC دیگر، آموزش HMIS برای ۵ کارمند، پیگیری تدارکات دوا. پلان ربع

۲.۴ خلاصه اجرائی (Executive Summary)**مفهوم ساده**

کسی که وقت ندارد کل راپور را بخواند. مدیران ارشد، داور و Executive Summary معمولاً فقط همین را می‌خوانند PPHD یعنی خلاصه راپور برای

- کوتاه: نصف صفحه - بیشتر نه
- در ابتدا: نتیجه اصلی را بگو - بعد جزئیات
- مشکلات کلیدی: ۲-۳ مشکل اصلی
- درخواست: اگر چیزی می‌خواهی، واضح بگو

حفظ کن

«خلاصه بنویس» - با نتیجه شروع کن، نه با مقدمه Executive Summary = نتیجه اول، توضیح بعد. در امتحان، اگر گفتند

۲.۵ پلان اقدام (Action Plan)

مفهوم ساده

چه مشکل؟ چه اقدام؟ کی؟ کی مسئول؟ چطور چک می‌شود؟ Action Plan
مشکل را نمی‌گوییم، برای حل آن پلان داری Action Plan یعنی جدولی که می‌گوید:
در راپور خیلی مهم است - چون نشان می‌دهد تو فقط

مشکل	اقدام	مسئول	زمان	موفقیت شاخص
Stock Card به روز نیست	پیگیری هفتگی آموزش مجدد +	Coordinator	تا ۱۵ ماه	Stock Card به روز
دیر می‌شود راپور HMIS	با کلینیک‌ها تماس هفتگی	HMIS Officer	هر هفته	Reporting Rate > ۹۵%
دوا تمام شده	به تدارکات درخواست فوری	Coordinator	فوری	دوا در ۱ هفته

مثال از دایکندی - Action Plan نظارت BHC نیلی، ماه حمل ۱۴۰۵

مشکل	اقدام	مسئول	زمان	موفقیت شاخص
TB Register ناقص است	مسئول TB آموزش مجدد	Coordinator + HMIS Officer	تا ۱۰ ثور	ثبت TB کامل
Stock Card به روز نیست	+ چک مجدد پیگیری هفتگی	Coordinator	هر هفته	Stock Card به روز
ثبت نمی‌شود کارمندان حاضری	مسئول کلینیک یادآوری به	Coordinator	فوری	روزانه ثبت شود حاضری

آموخته‌شده (Challenges & Lessons Learned) ۲.۶ چالش‌ها و درس‌های

Lessons Learned	Challenges	
گرفتنی که دفعه بعد بهتر کنی چه یاد	مشکلاتی که در کار داشتی	چیست؟
را قبل از زمستان شروع کنم» «باید تدارکات	«دوا دیر رسید»	مثال
برای بهبود	برای شفافیت	برای کی؟

برای امتحان

خوب = کسی که مشکلات را صادقانه می‌نویسد و برای آن‌ها راه‌حل پیشنهاد می‌کند.
در راپور، هیچ‌وقت مشکل را پنهان نکن. Coordinator

۲.۷ راپور حادثه‌ای (Incident Report)

مفهوم ساده

– مثل حمله، دزدی، مرگ کارمند، آتش‌سوزی یا مشکل امنیتی Incident Report
یعنی راپور فوری درباره یک حادثه

بخش	چه بنویسی؟
۱. تاریخ و وقت	کی اتفاق افتاد؟
۲. مکان	کجا؟ کدام کلینیک/ولسوالی؟
۳. شرح حادثه	چه اتفاق افتاد؟
۴. افراد متأثر	کی آسیب دید؟
۵. اقدام فوری	چه کار کردی؟
۶. اقدام بعدی	چه پلانی داری؟

حفظ کن

بعد. اگر حادثه امنیتی یا صحنه جدی است، همان روز راپور بده = Incident Report
فوری؛ نه یک هفته

۲.۸ راپورنویسی – اشتباهات رایج

اشتباهات رایج

- × اشتباه ۱: راپور طولانی و پر از کلمات تکراری.
- ✓ درست: کوتاه، واضح، با جدول و آمار.

اشتباهات رایج

- × اشتباه ۲: فقط مشکل را گفتن، بدون راه‌حل.
- ✓ درست: هر مشکل باید Action Plan داشته باشد.

اشتباهات رایج

۸۰ اشتباه ۳: آمار دادن بدون تحلیل.

۷۰ درست: «Reporting Rate ۷۰٪ است» + «چرا؟» + «چه اقدام؟»

اشتباهات رایج

۸۰ اشتباه ۴: پنهان کردن مشکلات.

۷۰ مشکلات را صادقانه بنویس - PPHD و دفتر مرکزی برای کمک هستند.

درست:

اشتباهات رایج

۸۰ اشتباه ۵: دیر فرستادن راپور.

۷۰ درست: راپور به موقع = اعتماد؛ راپور دیر = مشکل.

۲.۹ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه

کارمند؛ جلسه با ۲ PPHD: جلسه. سؤال: راپور ماهوار بنویس - با ساختار کامل. Stock Card به روز نداشتند؛ یک کلینیک در اشتراکی راپور نفرستاده - علت: نبود ۸۵٪ HMIS Reporting Rate از ۲۰ کلینیک؛ ۸۰٪ Drug Availability؛ ۳ کلینیک دایکندی هستی. راپور ماهوار را باید بنویسی. معلومات: نظارت از ۴ BHC؛ ۱۷ تو Coordinator ولایت

جواب مدل - راپور ماهوار، ماه حمل ۱۴۰۵

ثور؛ پیگیری Stock Card در ۳ کلینیک تا ۱۰ ثور؛ درخواست دوا از تدارکات - فوری. راپور می‌شود. ۶. پلان آینده: آموزش HMIS برای کارمند موجود در اشتراک تا ۱۵ Drug کمبود. ۵. درس‌ها: نبود کارمند HMIS در ولسوالی‌های دور باعث تأخیر HMIS نفرستادند (یکی در اشتراک به دلیل نبود کارمند)؛ ۸۰٪ - ۲۰٪ Availability Supervision. مشکلات: ۳ کلینیک Stock Card به‌روز نداشتند؛ ۳ کلینیک راپور Visits: ۴.۴؛ Drug Availability: ۸۰٪؛ (۲۰٪ از HMIS Reporting Rate: ۸۵٪) (۱۷ ۲ جلسه هماهنگی با PPHD؛ جمع‌آوری راپور HMIS از ۱۷ کلینیک. ۳. نتایج: پوشش می‌دهد. ۲. فعالیت‌ها: نظارت از ۴ BHC در ولسوالی‌های نیلی و شهرستان؛ ۱. مقدمه: این راپور فعالیت‌های صحنه ولایت دایکندی را در ماه حمل ۱۴۰۵

مشکل	اقدام	مسئول	زمان
Stock Card	پیگیری + آموزش	Coordinator	۱۰ ثور
دیر HMIS	آموزش کارمند	HMIS Officer	۱۵ ثور
کمبود دوا	درخواست تدارکات	Coordinator	فوری

Sample Answer

Monthly Report - Daikundi Province - Hamal 1405. 1. Introduction: This report covers health activities in Daikundi during Hamal 1405. 2. Activities: Supervised 4 BHCs; held 2 coordination meetings with PPHD; collected HMIS reports from 17 facilities. 3. Results: HMIS Reporting Rate: 85%; Drug Availability: 80%. 4. Challenges: 3 facilities had incomplete stock cards; 3 facilities did not submit HMIS reports; 20% drug shortage. 5. Lessons Learned: Lack of HMIS staff in remote districts causes reporting delays. 6. Way Forward: Train existing staff on HMIS in Ashtarlay; follow up on stock cards; request emergency drug supply. Action Plan: [table with issue, action, responsible, deadline]

۲.۱۰ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

• راپور خوب = واضح + مختصر + قابل اقدام.

- ← Results ← Activities ← Narrative Report = Introduction
Way Forward. ← Lessons ← Challenges
- Executive Summary = نتیجه اول، توضیح بعد - نصف صفحه
 - Action Plan = مشکل + اقدام + مسئول + زمان + شاخص
 - Challenges & Lessons Learned = صادقانه بنویس، پنهان نکن
 - Incident Report = فوری - همان روز

آینده ← درس‌ها ← مشکلات ← نتایج ← فعالیت‌ها ← ساختار طلایی راپور: مقدمه
Action Plan ← پلان

جواب‌های طلایی فصل دوم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
راپور خوب چه ویژگی دارد؟	مختصر، قابل اقدام، صادق واضح،	Clear, concise, actionable, and honest.
Executive Summary چطور بنویسی؟	توضیح بعد - نصف صفحه نتیجه اول،	Start with the main result, then explain briefly – half a page.
مشکلی در راپور داشته باشی؟ اگر	بنویس + Action Plan بده صادقانه	Write it honestly and include an action plan.
بفرستی؟ Incident Report کی	همان روز - فوری	Same day – immediately.
دارد؟ Action Plan چه ستون‌هایی	زمان، شاخص موفقیت مشکل، اقدام، مسئول،	Issue, action, responsible, deadline, success indicator.
ماهوار با ربعوار چه فرق دارد؟ راپور	تحلیل عمیق‌تر و مقایسه‌ای ماهوار خلاصه‌تر - ربعوار	Monthly is shorter; quarterly includes deeper analysis and trends.

نکته آخر فصل دوم □

چه می‌خواهی» - راپور تو موفق است؛ اگر بگويد «این چه بود؟» - دوباره بنویس.
اگر PPHD راپور تو را بخواند و بگويد «فهميدم چه کار کردی، چه مشکلی داری و راپورنویسی = هنر نوشتن کوتاه و مفيد.

DHIS2 و MoPH، PPHD، HMIS

فصل سوم: نظام صحتی افغانستان،

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. سه سطح نظام صحتی افغانستان و وظیفه هر سطح را توضیح می‌دهی.
 ۲. تفاوت BPHS و EPHS و معیار جمعیتی هر نوع مرکز صحتی را می‌دانی.
 ۳. زنجیره معلومات صحتی (Register ← HMIS ← DHIS2 ← PPHD ← MoPH) را می‌شناسی.
 ۴. اساسی از چه راه تأمین می‌شود و نقش MoPH، WHO، UNICEF و PPHD چیست.
- می‌دانی امروز خدمات

چرا این فصل مهم است؟

کمی. در امتحان، سؤالات زیاد از ساختار صحتی، BPHS/EPHS و HMIS می‌آید. تو Coordinator صحتی هستی. اگر نظام صحتی را نشناسی، نمی‌توانی هماهنگ

۳.۱ ساختار صحتی افغانستان

مفهوم ساده

نظام صحتی افغانستان سه سطح دارد:

سطح	خدمات	مراکز
سطح اول - قریه	صحتی (Primary Care) خدمات اولیه	Health Post، BHC، CHC
سطح دوم - ولسوالی	ثانوی (Secondary Care) خدمات	ولسوالی، شفاخانه ولایتی شفاخانه
سطح سوم - مرکز	تخصصی (Tertiary Care) خدمات	شفاخانه‌های تخصصی شفاخانه‌های مرکزی،

وزارت صحت عامه (MoPH) در راس قرار دارد:

او چهار معینیت - خدمات صحتی، پالیسی و انکشاف، طب و غذا، و مالی و اداری.
• در رأس وزارت: وزیر صحت عامه؛ در کنار

صحت اولیه (PHC)، ریاست صحت مادر و طفل، و ریاست پلان و هماهنگی.
ریاست هماهنگی صحت ولایات (Provincial Health Coordination)، ریاست
زیر هر معینیت، ریاست‌های عمومی و تصدی‌های تخصصی کار می‌کنند - از جمله
•

وزارت، نهادهای مشورتی و هماهنگی برای تصمیم‌گیری‌های کلان صحتی اند.
• شورای عالی صحت عامه و مورد اجرائیه

در سطح ولایت:

- صحتی در ولایت را دارد: PPHD (Provincial Public Health Directorate): ریاست صحت عامه ولایت - مسئولیت هماهنگی تمام فعالیت‌های
- شریکان: PPHCC (Provincial Public Health Coordination Committee): آن اشتراک می‌کنند (UN، MoPH، NGOها) کمیته هماهنگی صحتی ولایت - تمام در.

مثال از دایکندی

باید در این جلسات اشتراک کنی، راپور SO را شریک کنی و مشکلات را مطرح کنی.
هستی. PPHD دایکندی رئیس دارد. PPHCC هر ماه یا هر ربع جلسه می‌کند. تو
تو SO Coordinator در دایکندی

۳.۲ BPHS و EPHS

EPHS	BPHS	
بسته خدمات شفاخانه‌ای	بسته خدمات صحتی اساسی	چیست؟
۲۰۰۵	۲۰۰۳	کی ساخته شد؟
جراحی، تخصص‌ها، خدمات شفاخانه‌ای،	وقایه، صحت مادر و طفل، صحت اولیه،	چه خدماتی؟
ولسوالی، شفاخانه ولایتی شفاخانه	Health Post، BHC، CHC	کجا؟

و حمایت ارجاعی EPHS. خدمات صحت اولیه و وقایه را ارائه می‌دهد BPHS را شامل می‌شود BPHS برای مراکز (Referral) خدمات سطح شفاخانه

مرکز	سطح	خدمات
Health Post	قریه	خدمات ابتدایی، ارجاع ساده
BHC (Basic Health Center)	قریه/ولسوالی	– صحت مادر، طفل، واکسین خدمات اساسی
CHC (Comprehensive Health Center)	ولسوالی	خدمات گسترده‌تر + تخت
شفاخانه ولسوالی	ولسوالی	BPHS + EPHS (مختلط)
شفاخانه ولایتی	ولایت	EPHS

آمار مهم

- BHC ۱۵,۰۰۰ نفر (برای هر ۱,۵۰۰-۱,۰۰۰ نفر (۱۵۰-۱۰۰ خانواده Health Post
- CHC ۱۵,۰۰۰-۳۰,۰۰۰ نفر (در ساحات بسیار دور، کمتر از ۳۰,۰۰۰-۱۵,۰۰۰ نفر
- شفاخانه ولایتی برای هر ۲۰۰,۰۰۰-۵۰۰,۰۰۰ نفر (معیارهای ۳۰۰,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰ نفر
- شفاخانه ولسوالی برای هر ۳۰,۰۰۰-۶۰,۰۰۰ نفر

(وزارت صحت عامه، BPHS).

دسترسی داشتند (منبع: WHO EMRO – Health Systems, Afghanistan).
ثبت شده بود و نزدیک به ۸۷٪ مردم در فاصله دو ساعته به خدمات صحتی
• در سال ۲۰۱۸ در افغانستان ۳,۱۳۵ مرکز صحتی فعال

مثال از دایکندی

نیاز به جراحی داشته باشد، به شفاخانه ولایتی دایکندی BPHS نیلی یک مرکز BHC
نیاز به تخصص بالاتر باشد، به کابل فرستاده می‌شود (EPHS) است. اگر یک مریض
ارجاع داده می‌شود. اگر

حفظ کن

(ولسوالی/ولایت = EPHS | خدمات اولیه صحتی (قریه/ولسوالی = BPHS)
(خدمات شفاخانه‌ای)

سیستم معلومات صحتی – HMIS ۳.۳

مفهوم ساده

کردن معلومات صحی (HMIS (Health Management Information System)
یعنی سیستم جمع‌آوری، ذخیره، تحلیل و شریک

چطور کار می‌کند؟ HMIS

مرکز صحی (Register)

جمع‌آوری معلومات ماهانه

فرستادن به PPHD/سازمان - تا هفتم ماه بعد (۷ روز پس از پایان ماه)

فرستادن راپور ربعوار به مرکز - تا پایان ماه اول ربع جدید

تحلیل و استفاده

مرحله	کی؟
مرکز صحی معلومات را جمع می‌کند	پایان هر ماه
راپور به PPHD/سازمان فرستاده می‌شود	تا هفتم ماه بعد (۷ روز پس از پایان ماه)
به مرکز می‌فرستد PPHD	پایان ماه اول ربع جدید

مثال از دایکندی

قبل از ۷ ثور به Register نیلی در پایان ماه حمل، تمام معلومات مریضان را از BHC ولایتی می‌فرستد. تو SO دایکندی و دفتر PPHD جمع می‌کند. راپور ماهانه را چک کنی که این راپور به‌موقع فرستاده شده و معلومات دقیق است (Coordinator) باید.

برای امتحان

کند، اصلاح کند و پیگیری کند Register مسئولیت دارد که معلومات با Coordinator مطابقت داشته باشد. اگر تفاوت باشد، باید بررسی

سیستم معلومات صحی دیجیتال - DHIS2 ۳.۴

مفهوم ساده

می‌شود MoPH یک سیستم معلومات صحی دیجیتال است که توسط DHIS2 معلومات از جوامع و مراکز صحی طراحی شده و در سطح بین‌المللی هم استفاده استفاده می‌شود. این سیستم برای جمع‌آوری، ذخیره، تحلیل و شریک کردن

چه کار می‌کند؟ DHIS2

- معلومات را از مراکز صحی جمع می‌کند
- تحلیل و گزارش‌دهی خودکار
- شاخص‌ها را محاسبه می‌کند
- دسترسی به معلومات را آسان می‌کند

مثال از دایکندی

را ببینی و تحلیل کنی - مثلاً ببینی که ANC Coverage در یک ولسوالی کم است. معلومات مریضان را در DHIS2 ثبت می‌کند. تو می‌توانی از دفتر ولایتی معلومات در BHC نیلی، کارمند HMIS

حفظ کن

صحی دیجیتال (نرم‌افزار = DHIS2 | (سیستم معلومات صحی (سیستم = HMIS (سیستم معلومات

و اسناد اصلی Register ۳.۵

مفهوم ساده

یعنی دفتری که مرکز صحتی در آن معلومات مریضان را ثبت می‌کند Register است. (Source Document) منبع اصلی معلومات Register

انواع Register:

- OPD Register: مریضان سرپایی
- ANC Register: مریضان زن باردار
- Delivery Register: ولادت‌ها
- TB Register: مریضان TB
- Vaccination Register: واکسین‌ها
- Stock Card: موجودی دوا

مثال از دایکندی

را چک می‌کنی. اگر فقط ۳۵ ثبت شده باشد، تفاوت ۱۵ نفر است. باید بررسی: چرا؟ نیلی می‌روی. راپور HMIS می‌گویند ۵۰ زن باردار ANC گرفته‌اند. تو ANC Register تو به BHC

برای امتحان

آیا معلومات با Register مطابقت دارد؟ اگر نه - چرا؟ چه اقدامی لازم است؟ همیشه پرس:

۳.۶ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه

مراجعه می‌کنی، فقط ۷۰ مریض ثبت شده. تفاوت: ۳۰ مریض. سؤال: چه می‌کنی؟ BHC اشتراکی در ماه گذشته ۱۰۰ مریض OPD داشته، اما وقتی به Register کلینیک تو Coordinator ولایت دایکندی هستی. راپور HMIS نشان می‌دهد که

جواب مدل

در راپور نظارت مستند می‌کنم و به PPHD اطلاع می‌دهم. هفته بعد پیگیری می‌کنم. مسئول کلینیک هدایت می‌دهم که اصلاح کند؛ اگر لازم باشد آموزش کوتاه می‌دهم. چند دوا مصرف شده؟ می‌توانم بفهمم کدام درست است. اگر مشکل ثبت باشد، به معلومات HMIS به اشتباه ثبت شده. با چک کردن اسناد دیگر (مثلاً Stock Card - Register ناقص ثبت شده، یا مطابقت ندارند. ممکن است چند دلیل داشته باشد: Register با راپور HMIS اول با مسئول کلینیک صحبت می‌کنم و از او می‌پرسم چرا Register و راپور HMIS

Sample Answer

First, I would discuss with the facility in-charge to understand the discrepancy. I would check other source documents, such as the pharmacy stock card and OPD register, to verify which data is accurate. If it is a recording issue, I would provide on-the-job feedback, ensure the register is updated, document the findings, report to PPHD, and follow up to confirm the data is accurate in the next reporting period.

۳.۷ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

- نظام صحتی افغانستان سه سطح دارد: قریه، ولسوالی، مرکز.
- خدمات شفاخانه‌ای = EPHS خدمات اولیه صحتی؛ = BPHS
- ۱۵,۰۰۰-۳۰,۰۰۰ نفر - شفاخانه ولسوالی برای هر ۱۰۰,۰۰۰-۳۰۰,۰۰۰ نفر BHC
- برای هر
- سیستم جمع‌آوری معلومات صحتی = HMIS
- سیستم معلومات صحتی دیجیتال = DHIS2
- Register = Register منبع اصلی معلومات؛ راپور باید با Register مطابقت.

تحلیل → مرکز → PPHD/NGO → راپور ماهانه → ساختار طلایی: Register

امروز (۱۴۰۵) - چیزهایی که در کار روزمره می‌بینی ۳.۸ نظام صحتی افغانستان

مفهوم ساده

باید این تفاوت را بدانند تا بفهمد راپورش به کی می‌رسد و تصمیم از کجا می‌آید. اما روش تأمین خدمات و پول آن بعد از ۲۰۲۱ تغییر کرده است. Coordinator ساختار BPHS/EPHS همان است که در بخش ۳.۲ خواندی،

چطور خدمات اساسی تأمین می‌شود؟

- را سازمان‌های غیردولتی (Service Providers) در هر ولایت تطبیق می‌کنند.
- وزارت صحت عامه (MoPH) پالیسی، معیار و نظارت را دارد؛ خدمات طریق صندوق‌های مشترک (مثل ARTF/بانک جهانی و ADB) تأمین می‌شود. صحت اولیه و WHO مسئول بخش عمده خدمات شفاخانه‌ای است؛ پول آن از BPHS/EPHS به سازمان ملل منتقل شد: UNICEF مسئول خدمات بعد از ۲۰۲۱، مدیریت قراردادهای اجرا می‌شد؛ پس برنامه‌های فعلی ادامه همان مدل contracting-out است. زیر پروژه «صحت‌مندی» (Sehatmandi) و قراردادهای مستقیم MoPH
- در دوره قبلی همین خدمات در ولایت، نقش هماهنگی، نظارت و تأیید را دارد؛ سازمان تو PPHD
- ها است Service Provider یکی از (Shuhada Organization)

چه چیزی در چند سال اخیر تغییر کرده؟

- شد و در ۲۰۲۵ نیز با قطع بخشی از کمک‌ها، صدها مرکز دیگر به تعلیق رفت. از ۳,۰۰۰ مرکز فعال بود؛ در سال‌های بعد این تعداد به صورت محسوس کم
- تعداد مراکز صحتی فعال کاهش یافته است. در اوج (اواخر دهه ۲۰۱۰) بیش Stock-out و ترک وظیفه کارمندان در ولایات دور، ریسک‌های روزمره است. دوا، حقوق کارمندان و بعضی برنامه‌های صحتی آسیب دیده است؛ این یعنی
- تأمین صحتی عامه تا پایان ۲۰۲۶ تمدید شده؛ اما شرایط مالی بی‌ثبات است.
- کمک‌ها برای برنامه‌های

این برای Coordinator چه معنی دارد؟

پول و ادامه خدمات مهم است - گزارش دقیق = دفاع از خدمات برای مردم.

۱. راپور و نظارت تو، برای ادامه

به PPHD و UNICEF/WHO کمک می‌کند تا برای ولایت تو منابع بگیرند.

۲. هر Stock-out یا ترک وظیفه را مستند کن؛ این معلومات

در ولایت عوض شوند. رابطه کاری با PPHD را نگه دار و اسناد را منظم نگه دار.

تغییر داشته باش: شرکای تأمین‌کننده، پروژه‌ها و شاید سازمان تطبیق‌کننده

۳. انتظار

و بلندترین منبع را نخوان - با PPHD ولایت خودت و دفتر مرکزی تماس بگیر.

۴. برای معلومات دقیق و به‌روز، راپورترین

چه چیزی را بازبینی کن (تابستان ۱۴۰۵): - چون ممکن است تغییر کرده باشد.

نام پروژه فعلی، شریک مالی، و کانال گزارش‌دهی ولایت خودت

جواب‌های طلایی فصل سوم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
چه فرق دارد؟ EPHS با BPHS	اولیه صحتی است؛ BPHS شفاخانه‌ای EPHS خدمات خدمات	BPHS provides primary health care; EPHS provides hospital-level services.
چیست؟ HMIS	و تحلیل معلومات صحتی سیستم جمع‌آوری، ذخیره	A system for collecting, storing, and analyzing health data.
چیست؟ DHIS2	معلومات صحتی دیجیتال سیستم	A digital health information system.
مطابقت نداشته باشد؟ اگر معلومات با Register	کن، اصلاح کن، پیگیری کن بررسی کن، علت را پیدا	Verify, identify the cause, correct it, and follow up.
چیست؟ PPHD	ریاست صحت عامه ولایت	Provincial Public Health Directorate.

Provincial Public Health Coordination Committee.	کمیته هماهنگی صحتی ولایت	چیست؟ PPHCC
---	--------------------------	-------------

نکته آخر فصل سوم

نظام صحتی را بشناس تا بتوانی هماهنگ کنی. Register → HMIS → DHIS2 →
PPHD →. این زنجیر را حفظ کن - MoPH

چهارم: تدارکات، دوا، لوژستیک و دارایی‌ها

فصل

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. چرخه تدارکات (نیاز ← درخواست ← تأیید ← خریداری ← تحویل ← می‌دهی. ثبت) را توضیح
۲. محاسبه می‌کنی و برای موجودی تصمیم می‌گیری Reorder Point و AMC.
۳. فوراً مدیریت می‌کنی و علت ریشه‌ای آن را پیدا می‌کنی Stock-out.
۴. پلان زمستانی‌سازی و حفظ زنجیره سرد را برای مراکز دورافتاده می‌نویسی.

چرا این فصل مهم است؟

دارد که دوا به‌موقع برسد، موجودی مدیریت شود و از Stock-out جلوگیری کند. دوا = زندگی. اگر دوا نباشد، جان مریض در خطر است. Coordinator مسئولیت در محیط صحنه،

۴.۱ تدارکات (Procurement)

مفهوم ساده

درخواست خرید NGO یعنی خریداری دوا، تجهیزات و سایر اقلام. در Procurement شروع می‌شود (Purchase Requisition) ها، تدارکات معمولاً از طریق شناسایی نیاز ← درخواست خرید (Requisition)

تأیید از Coordinator

ارسال به دفتر مرکزی/تدارکات

خریداری (Procurement)

تحویل به مرکز صحی

ثبت در Stock Card

مثال از دایکندی

دارد. مسئول کلینیک درخواست خرید می‌دهد. تو Paracetamol نیلی نیاز به BHC می‌رود. تدارکات دوا را خریداری می‌کند و به کلینیک می‌رساند (Coordinator). تأیید می‌کنی که نیاز واقعی است. درخواست به دفتر مرکزی ولایتی

حفظ کن

Recording → Delivery → Procurement → Approval → Requisition

۴.۲ مصرف متوسط ماهانه (AMC)

مفهوم ساده

یعنی میانگین مصرف ماهانه یک دوا. از AMC (Average Monthly Consumption) می‌شود تا بفهمیم یک دوا چقدر باقی می‌ماند و کی باید سفارش بدهیم AMC استفاده.

$$\text{AMC} = \frac{\text{مجموع مصرف در ۳ ماه}}{۳}$$

مثال از دایکندی

دانه ۰ حوت: ۳۲۰ دانه ۰ Paracetamol نیلی در ۳ ماه گذشته: جدی: ۳۰۰ دانه BHC دلو: ۲۸۰
= ۳۰۰ دانه در ماه. اگر موجودی فعلی ۶۰۰ دانه باشد، یعنی برای ۲ ماه کافی است.
مجموع: ۹۰۰ ۳

برای امتحان

می‌شود Reorder Point میانگین مصرف ماهانه؛ از آن برای محاسبه AMC استفاده.

۴.۳ موجودی (Stock) و Stock Card

مفهوم ساده

و تاریخ انقضا Stock Card یعنی کارت ثبت موجودی. هر دوا یک Stock Card تاریخ دریافت، مقدار دریافت، تاریخ مصرف، مقدار مصرف، موجودی باقی‌مانده دارد. در آن ثبت می‌شود:

نمونه Stock Card - Paracetamol 500mg - BHC نیلی

تاریخ	شرح	دریافت	مصرف	موجودی
۱ حمل	موجودی اولیه	-	-	۵۰۰
۵ حمل	از تدارکات دریافت	۳۰۰	-	۸۰۰
۱۰ حمل	مصرف OPD	-	۱۰۰	۷۰۰
۲۰ حمل	مصرف OPD	-	۱۵۰	۵۵۰

Physical Count

شمرده شود و با Stock Card مقایسه شود. اگر تفاوت باشد، باید بررسی شود.
هر ماه باید موجودی فیزیکی

حفظ کن

شمردن فیزیکی موجودی = Physical Count | کارت ثبت موجودی = Stock Card

۴.۴ نقطه سفارش مجدد (Reorder Point)

مفهوم ساده

یعنی مقدار موجودی که وقتی به آن رسید، باید فوراً سفارش بدهی Reorder Point.
زمان تحویل (به ماه) + ذخیره احتیاطی = Reorder Point = AMC

مثال از دایکندی

(دانه؛ زمان تحویل = ۱ ماه؛ ذخیره احتیاطی = ۲ ماه (۶۰۰ دانه) AMC = ۳۰۰).
به ۹۰۰ دانه رسید، باید سفارش بدهی ۹۰۰ = ۶۰۰ + ۳۰۰ = Reorder Point
دانه - یعنی وقتی موجودی

برای امتحان

اگر موجودی به Reorder Point رسید و سفارش ندادی → می‌شود Stock-out

۴.۵ کمبود دوا (Stock-out) - چطور مدیریت کنیم؟

مفهوم ساده

نه Issue یعنی دوا تمام شده و مریض نمی‌تواند خدمات بگیرد. این یک Stock-out Risk است -

علت	اقدام
تدارکات دیر رسیده	پیگیری فوری + اطلاع به PPHD
مصرف زیاد از حد انتظار	بررسی علت + اصلاح سفارش بعدی
ثبت نشده Stock Card	آموزش + پیگیری
مشکل امنیتی در راه	هماهنگی با PPHD + منابع محلی

مثال از دایکندی - BHC شهرستان دوا تمام کرده

- با تدارکات ولایتی تماس می‌گیری ۲. از PPHD کمک می‌خواهی
- ممکن باشد از BHC نزدیک‌تر دوا قرض می‌گیری ۴. به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهی
- اگر
- پیگیری می‌کنی تا دوا برسد

برای امتحان

سناریو Stock-out، اولویت اول = حل فوری. بعد علت را پیدا کن. بعد پیگیری کن. در

۴.۶ زمستانی‌سازی (Winterization)

مفهوم ساده

برسانی، سوخت و گرمی‌کننده تهیه کنی و ذخیره احتیاطی بسازی Winterization در زمستان بسته می‌شود. باید قبل از زمستان: دوا و تجهیزات را به مراکز دورافتاده. یعنی آمادگی برای زمستان. در دایکندی، راه‌ها زنجیره سرد (Cold Chain) انبارهای زنجیره سرد برای واکسین‌ها باید دمای ۲- تا ۸- درجه سانتی‌گراد را حفظ کنند.

مثال از دایکندی

و کیتی. اگر تا قوس نرسانی، راه‌ها بسته می‌شود و مراکز صحن بدون دوا می‌مانند. کنی به فرستادن دوا و تجهیزات به BHC های دورافتاده در ولسوالی‌های اشتراکی در ماه میزان باید شروع

حفظ کن

شروع: ماه میزان - نه قوس. اگر دیر کنی، راه بسته می‌شود Winterization = آمادگی قبل از زمستان.

۴.۷ مدیریت دارایی‌ها (Asset Management)

مفهوم ساده

یعنی دارایی‌های سازمان - مثل موتر، کمپیوتر، تجهیزات طبی و فرنیچر Asset در آن ثبت می‌شود - با شماره، تاریخ خرید، قیمت و موقعیت Asset Register. دفتری است که تمام دارایی‌ها

مثال از دایکندی

خرید، قیمت، مسئول استفاده. هر سال باید Physical Verification انجام شود. ولایتی SO در نیلی موجود است. در Asset Register ثبت شده: شماره اموال، تاریخ یک کمپیوتر در دفتر

۴.۸ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه

موجودی ۲۰۰ دانه است Amoxicillin نیلی نشان می‌دهد که Stock Card BHC
 = ۱ ماه؛ ذخیره احتیاطی = ۲ ماه. سؤال: آیا باید سفارش بدهی؟ چرا؟ $AMC = 150$
 دانه؛ زمان تحویل

جواب مدل

موجودی فعلی ۲۰۰ دانه است - کمتر از $450 = 150 + 300 = \text{Reorder Point}$
 Stock-out، یعنی باید فوراً سفارش بدهی؛ اگر دیر کنی. Reorder Point دانه.
 می‌شود

Sample Answer

$\text{Reorder Point} = AMC \text{ Lead Time} + \text{Safety Stock} = 150 + 300 = 450$.
 Current stock is 200, which is below the reorder point. I must place an
 order immediately to prevent a stock-out.

۴.۹ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

- خریداری دوا و تجهیزات = Procurement
- میانگین مصرف ماهانه = AMC
- شمردن فیزیکی = Physical Count کارت ثبت موجودی؛ Stock Card
- زمان تحویل + ذخیره احتیاطی $\text{Reorder Point} = AMC$
- فوراً حل کن، بعد علت را پیدا کن - $\text{Stock-out} = \text{Issue}$
- آمادگی قبل از زمستان - شروع از میزان Winterization

فرمول طلایی: $\text{Reorder Point} = (AMC \text{ Lead Time}) + \text{Safety Stock}$

جواب‌های طلایی فصل چهارم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
--------------	------------------	-------------------------

Average Monthly Consumption.	میانگین مصرف ماهانه	چیست؟ AMC
A card for recording drug stock movements.	کارت ثبت موجودی دوا	چیست؟ Stock Card
AMC Lead Time + Safety Stock.	AMC + ذخیره احتیاطی زمان تحویل	می‌شود؟ Reorder Point چطور محاسبه
Solve immediately, find the cause, and follow up.	علت را پیدا کن، پیگیری کن فوراً حل کن،	Stock-out شود چه می‌کنی؟ اگر دوا
Preparing before winter to deliver medicines to remote facilities.	از زمستان برای رساندن دوا آمادگی قبل	چیست؟ Winterization
Physically counting stock on hand.	شمردن فیزیکی موجودی	چیست؟ Physical Count

نکته آخر فصل چهارم

دوا = زندگی؛ اگر Stock-out شود، مریض آسیب می‌بیند. AMC → Stock Card → Reorder Point → پیگیری - این چرخه را حفظ کن.

فصل پنجم: مدیریت مالی

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

بودجه، پلان شده و واقعی را با هم مقایسه می‌کنی و Variance را محاسبه می‌کنی.
۱.

می‌گیری و آن را با اسناد درست تصفیه می‌کنی Advance ۲.

۳. اسناد حمایتی هر مصرف را می‌شناسی و می‌دانی بدون سند چه می‌شود.

۴. خود را برای Audit داخلی و خارجی آماده می‌کنی.

چرا این فصل مهم است؟

و چطور راپور داده می‌شود. اگر مالی را نفهمی، نمی‌توانی تدارکات Coordinator را مدیریت کنی HR، باید بداند پول چطور مصرف می‌شود، چطور تصفیه می‌شود و فعالیت‌ها.

۵.۱ بودجه (Budget)

مفهوم ساده

یعنی پلان پولی: برای چه فعالیتی، چقدر پول، در چه زمانی Budget

نوع	مثال
بودجه ماهانه	مصرف ماهانه دفتر
بودجه ربعوار	فعالیت‌های ربع
بودجه سالانه	پلان سالانه

مثال از دایکندی

دوا ۳۰,۰۰۰ افغانی؛ سوخت و ترانسپورت ۱۰,۰۰۰ افغانی؛ مجموع: ۹۰,۰۰۰ افغانی. SO در دایکندی ممکن است شامل: معاشات کارمندان ۵۰,۰۰۰ افغانی؛ تدارکات بودجه ماهانه

۵.۲ پلان‌شده در مقابل واقعی (Planned vs Actual)

مفهوم ساده

چقدر واقعاً مصرف کردی = Actual چقدر پلان کردی؛ = Planned

	پلان‌شده	واقعی	تفاوت
معاشات	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
دوا	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-۵,۰۰۰
سوخت	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	+۲,۰۰۰

حفظ کن

مقایسه پلان با واقعیت = Planned vs Actual

۵.۳ تفاوت بودجه (Variance)

مفهوم ساده

یعنی تفاوت بین مقدار پلان‌شده و مقدار واقعی Variance

مثال: پلان مصرف دوا ۳۰,۰۰۰ افغانی؛ مصرف واقعی ۳۵,۰۰۰ افغانی → Variance ۵,۰۰۰ افغانی

اما سؤال مهم فقط «چقدر تفاوت است؟» نیست. Coordinator باید بیپرسد:

- چرا؟ - آیا موجه است؟ (مثلاً قیمت دوا بلند شده یا مصرف زیاد شده؟)
- آیا مشکل است؟ - اگر Variance بزرگ باشد، باید بررسی شود.
- چه اقدامی لازم است؟ - اصلاح بودجه ماه بعد؟ گزارش به دفتر مرکزی؟

برای امتحان

مثبت باشد Variance اگر $\text{Variance} = \text{Planned} - \text{Actual}$ - شده؛ اگر منفی باشد کمتر مصرف - بیشتر مصرف شده.

۵.۴ پیش‌پرداخت (Advance)

مفهوم ساده

از مصرف به یک کارمند یا دفتر داده می‌شود - برای انجام یک فعالیت Advance. یعنی پولی که قبل

مثال از دایکندی

می‌گیری برای سفر نظارتی به ولسوالی اشتدلی. بعد از سفر، باید تصفیه کنی. تو Advance

حفظ کن

راپور مصرف پول + اسناد = (Clearance) پول پیش‌پرداخت | تصفیه = Advance

۵.۵ تصفیه پیش‌پرداخت (Advance Clearance)

مفهوم ساده

را برای همان کاری که گرفتی، مصرف کردی - Advance یعنی تصفیه Clearance. یعنی ثابت کنی پول اسناد مورد نیاز برای تصفیه:

- فاکتور (Invoice) • رسید (Receipt)
- حاضری (اگر مربوط به آموزش باشد) • راپور سفر (اگر مربوط به نظارت باشد)
- لیست

مثال از دایکندی

۹,۰۰۰ افغانی. باقی ۱,۰۰۰ افغانی را برمی‌گردانی و اسناد را تصفیه می‌کنی Advance
۶,۰۰۰ (رسید داری)؛ غذا ۲,۰۰۰ (رسید داری)؛ متفرقه ۱,۰۰۰ (رسید داری). مجموع:
گرفتی: ۱۰,۰۰۰ افغانی برای سفر نظارتی به اشتراکی. مصرف: سوخت

برای امتحان

باید در زمان مشخص تصفیه شود. اگر دیر کنی، مشکل مالی می‌شود Advance

۵.۶ اسناد حمایتی (Supporting Documents)

مفهوم ساده

اسنادی که ثابت می‌کند پول درست مصرف شده: فاکتور Supporting Documents
لیست حاضری (Contract)، قرارداد (Receipt)، رسید (Invoice)، یعنی
(Attendance Sheet)، راپور فعالیت (Activity Report).

حفظ کن

هیچ مصرفی بدون سند قبول نمی‌شود. No document = No payment.

۵.۷ پول نقد (Cash) و مدیریت آن

مفهوم ساده

پول نقد - چقدر داری، چقدر مصرف کردی، چقدر باقی مانده. اصول اساسی:
مدیریت Cash یعنی کنترل

- روزانه یا هفتگی Cash Count
- ثبت در Cash Book
- هیچ پولی بدون سند مصرف نشود
- قفل باشد Cash Box

مثال از دایکندی

Cash می‌کنی و با Cash Book مقایسه می‌کنی. اگر تفاوت باشد، باید بررسی شود. دفتر ولایتی SO در نیلی ۲۰,۰۰۰ افغانی Cash دارد. هر هفته Count

۵.۸ حسابرسی (Audit)

مفهوم ساده

کنند و راپور آن را به Audit ها موظف هستند سالانه NGO. یعنی بررسی مالی Audit ارائه دهند MoPH.

نوع	کی؟	توسط کی؟
داخلی (Internal)	در جریان کار	تیم داخلی سازمان
خارجی (External)	سالانه	شرکت Audit خارجی
دوینر	در صورت ضرورت	دوینر

مثال از دایکندی

تمام اسناد را آماده داشته باشی – فاکتورها، رسیدها، تصفیه Advance ها، راپورها. Audit خارجی می‌آید و اسناد مالی دفتر SO دایکندی را بررسی می‌کند. تو باید یک شرکت

برای امتحان

آسان است Audit، بررسی مالی؛ اگر اسناد کامل باشد = Audit

۵.۹ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه

افغانی؛ مصرف واقعی: ۳۵,۰۰۰ افغانی. سؤال: Variance چقدر است؟ چه می‌کنی؟ بودجه ماهانه دوا: ۳۰,۰۰۰

جواب مدل

Variance = ۳۰,۰۰۰ - ۳۵,۰۰۰ = -۵,۰۰۰ می‌کنم
توضیح می‌دهم و از تکرار جلوگیری می‌کنم
می‌کنم. اگر موجه باشد، بودجه ماه بعد را اصلاح می‌کنم؛ اگر غیرموجه باشد،
شده؟ آیا تدارکات دیر رسیده و از جای دیگر خریده‌ایم؟ بعد با دفتر مرکزی صحبت
مصرف شده). اول علت را پیدا می‌کنم: آیا قیمت دوا بلند شده؟ آیا مصرف زیاد
افغانی (۵,۰۰۰) افغانی بیشتر

Sample Answer

Variance = 30,000 - 35,000 = -5,000 AFN (over-spent). First, I would
investigate the cause: Was there a price increase, increased
consumption, or emergency procurement? Then I would discuss with
the central office. If justified, I would adjust the next month's budget. If
not, I would provide an explanation and take corrective action to prevent
recurrence.

۵.۱۰ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

- پلان پولی = Budget
- مقایسه پلان با واقعیت = Planned vs Actual
- Variance = Planned - Actual.
- تصفیه = Clearance پول پیش‌پرداخت؛ Advance
- Supporting Documents = بدون سند، هیچ مصرفی قبول نیست
- اسناد حمایتی
- بررسی مالی - اسناد را آماده داشته باش = Audit

فرمول تلای: Variance = Planned - Actual

جواب‌های تلای فصل پنجم

سؤال احتمالی	جواب تلای (دری)	Sample Answer (English)
--------------	-----------------	-------------------------

The difference between planned and actual.	تفاوت بین پلان شده و واقعی	چیست؟ Variance
Pre-payment for activities.	پول پیش پرداخت	چیست؟ Advance
Settling an advance with supporting documents.	تصفیه Advance با اسناد	چیست؟ Clearance
Invoices, receipts, contracts.	فاکتور، رسید، قرارداد	Supporting Documents چیست؟
Financial review.	بررسی مالی	چیست؟ Audit
Investigate the cause and discuss with the central office.	کن، با دفتر مرکزی صحبت کن علت را پیدا	بزرگ باشد چه می کنی؟ اگر Variance

نکته آخر فصل پنجم

پول امانت است؛ هر افغانی که مصرف می شود، باید سند داشته باشد. → Advance
مصرف → اسناد → تصفیه - این چرخه را حفظ کن.

فصل ششم: منابع بشری و اداره

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. روند استخدام را مطابق ToR و پالیسی سازمان اجرا می‌کنی.
۲. حاضری، رخصتی و ارزیابی عملکرد را مدیریت می‌کنی.
۳. روند اجرای اداری را عادلانه و مستند پیش می‌بری.
- PSEA را می‌دانی و می‌دانی در صورت شک یا شکایت، چطور و به کی گزارش بدهی.
۴. اصول

چرا این فصل مهم است؟

کار می‌کند - استخدام، حاضری، اجرای اداری، رفع مشکلات. اگر Coordinator را نفهمی، تیم را نمی‌توانی مدیریت کنی HR با مردم

۶.۱ استخدام (Recruitment)

مفهوم ساده

یعنی پیدا کردن و استخدام کردن کارمند مناسب Recruitment

شناسایی نیاز → ToR/Job Description

اعلان وظیفه (Vacancy Announcement)

جمع‌آوری CVها → Shortlisting

امتحان + مصاحبه

انتخاب + قرارداد

مثال از دایکندی

با دفتر مرکزی هماهنگ می‌کند Coordinator. نیلی نیاز به یک قابله دارد BHC. و کانال‌های محلی نشر می‌شود ACBAR نوشته می‌شود. اعلان در وبسایت ToR برگزار می‌شود و قابله انتخاب و قرارداد می‌شود Shortlisting، ها جمع می‌شود CV. انجام می‌شود، امتحان و مصاحبه

برای امتحان

نیاز = Recruitment → ToR → اعلان → Shortlisting → امتحان/مصاحبه → انتخاب

۶.۲ شرح وظایف (ToR)

مفهوم ساده

به کی راپور می‌دهد، چه مهارت‌هایی لازم دارد (Terms of Reference) ToR تجربه و مسئول راپوردهی ToR. یعنی شرح وظایف: این کارمند چه کار می‌کند، خوب شامل: عنوان وظیفه، هدف، وظایف اصلی، مهارت‌های لازم، تحصیلات،

نمونه - ToR قابله، BHC نیلی

هدف: ارائه خدمات صحت مادر و طفل در BHC نیلی. انجام ولادت طبیعی؛ ارجاع موارد پیچیده به شفاخانه؛ ثبت معلومات در Register. وظایف: ارائه ANC و PNC؛ تصدیق‌شده، تجربه ۲ ساله. راپوردهی: به Coordinator ولایتی و مسئول کلینیک. مهارت‌ها: قابله

۶.۳ لیست کوتاه (Shortlisting)

مفهوم ساده

تحصیلات مطابق CV یعنی انتخاب کاندیدان واجد شرایط از میان Shortlisting. کامل CV، ToR مهارت‌های مطابق، ToR تجربه مطابق، ToR ها. معیارها:

مثال از دایکندی

دارند و ToR برای وظیفه قابله می‌رسد. ۱۰ نفر تحصیلات و تجربه مطابق CV ۲۰ (می‌شوند؛ ۱۰ نفر دیگر رد می‌شوند (با دلیل Shortlist).

۶.۴ مصاحبه (Interview)

مفهوم ساده

یعنی ملاقات با کاندید برای ارزیابی مهارت‌ها، تجربه و مناسب بودن Interview چه می‌کنی؟ چطور با تیم کار می‌کنی؟ اگر مشکلی پیش بیاید چطور حل می‌کنی؟ نمونه سؤالات: تجربه قبلی‌ات چیست؟ اگر یک مریض بحرانی بیاید

مثال مصاحبه

اطلاع می‌دهم، مریض را برای ارجاع آماده می‌کنم و در Register ثبت می‌کنم. «بیاید، چه می‌کنی؟» جواب خوب: «اول علائم حیاتی را چک می‌کنم، فوراً به داکتر از یک قابله کاندید پرسیده می‌شود: «اگر یک زن باردار با خونریزی

۶.۵ حاضری (Attendance)

مفهوم ساده

می‌کنند. Coordinator هر ماه چک می‌کند که Attendance با راپور مطابقت دارد. هر مرکز صحنی یک Attendance Sheet دارد. کارمندان هر روز صبح امضا

حفظ کن

حاضری؛ اگر کارمند حاضر نباشد، خدمات متوقف می‌شود = Attendance

۶.۶ رخصتی (Leave)

مفهوم ساده

انواع رخصتی: رخصتی سالانه، رخصتی مریضی، رخصتی زایمان، رخصتی اضطراری.

مثال از دایکندی

موقت پیدا کنی؛ به PPHD اطلاع بدهی؛ مطمئن شوی که خدمات متوقف نمی‌شود. نیلی درخواست رخصتی زایمان می‌دهد. تو باید: درخواست را بررسی کنی؛ جانشین یک قابله در BHC

۶.۷ ارزیابی عملکرد (Performance)

مفهوم ساده

کیفیت کار، حضری، همکاری با تیم، رعایت قوانین Performance Evaluation. یعنی ارزیابی کار کارمند - هر سال یا هر ۶ ماه. معیارها:

مثال از دایکندی

آیا معلومات دقیق است؟ آیا آموزش دیده؟ اگر ضعیف باشد، پلان بهبود می‌سازی. تو عملکرد یک کارمند HMIS را ارزیابی می‌کنی: آیا راپورها به‌موقع فرستاده؟

۶.۸ اجرایات (Disciplinary Process)

مفهوم ساده

تخلف → تحقیق → شنیدن دفاع کارمند

تصمیم (تذکر، جریمه، اخراج)

ثبت در فایل کارمند

مثال از دایکندی

موجه نباشد، تذکر کتبی می‌دهی. اگر تکرار شود، به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهی. اجازه ۳ روز غایب می‌شود. تو تحقیق می‌کنی، از او توضیح می‌خواهی. اگر دلیل یک کارمند بدون

برای امتحان

اجرايات بايد عادلانه، مستند و مطابق پاليسي باشد.

۶.۹ محرمت (Confidentiality)

مفهوم ساده

معلومات مريضان و معلومات کارمندان - همه محرم است Confidentiality. یعنی حفظ محرمت معلومات.

مثال از دایکندی

قریه، نه به خانواده مريض بدون اجازه. فقط تیم صحتی مربوط دسترسی دارد. در BHC نیلی ثبت شده. تو نباید این معلومات را به کسی بگویی - نه به شورای یک مريض HIV مثبت

۶.۱۰ حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی (PSEA)

مفهوم ساده

تمام کارمندان PSEA (Protection from Sexual Exploitation and Abuse) کنند PSEA ها باید اصول NGO یعنی حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی. را رعایت

شش اصل اساسی PSEA:

اصول شش‌گانه IASC:

کارمندان بشردوستانه، تخلف سنگین کاری است و موجب اخراج از وظیفه می‌شود.
۱. استثمار و سوء استفاده جنسی از سوی

به سن قانونی یا رضایت محلی. ادعای نادانی در مورد سن، عذر پذیرفته نیست.

۲. فعالیت جنسی با افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است - بدون توجه

جنسی - از جمله استفاده از کمک‌هایی که حق مستفیدان است - ممنوع است.

۳. تبادل پول، مال، کار یا خدمات در بدل رابطه

را مطلقاً ممنوع کرده‌اند و استفاده نادرست از مقام و جایگاه برای آن، تخلف است.

شده و اعتبار کمک بشردوستانه را آسیب می‌زند. در عمل، اکثر سازمان‌ها این روابط و مستفیدان برنامه‌ها به شدت منع شده است، زیرا بر عدم توازن قدرت بنا

۴. روابط جنسی میان کارمندان بشردوستانه

- شک یا نگرانی داشته باشد، مکلف است آن را از راه‌های رسمی گزارش بدهد.

استفاده یا استثمار جنسی از سوی همکار خود - در همین سازمان یا سازمان دیگر

۵. اگر کارمند بشردوستانه در مورد سوء

مدیران در همه سطوح مسئولیت ویژه‌ای برای ساختن و حفظ چنین محیطی دارند.

محیطی را ایجاد و حفظ کند که از استثمار و سوء استفاده جنسی جلوگیری شود؛

۶. هر کارمند مکلف است

در سازمان خود: و به تیم خود هم معرفی کن - قبل از اینکه حادثه‌ای پیش بیاید.

کانال گزارش‌دهی PSEA، نام مسئول PSEA و خط تماس محرمانه را از قبل بشناس

حفظ کن

گزارش الزامی. اگر چیزی ببینی یا بشنوی، باید گزارش بدهی. خاموش نشو = PSEA
عدم تحمل مطلق +

۶.۱۱ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه

در BHC نیلی متهم به رفتار نادرست با یک مریض زن شده. سؤال: چه می‌کنی؟
یک کارمند

جواب مدل

مراحل مستند می‌شود. هیچ تصمیمی بدون تحقیق و مطابق پالیسی گرفته نمی‌شود. گذاشته می‌شود تا تحقیق کامل شود. مریض حمایت روانی و صحت می‌شود. تمام مسئول PSEA تماس می‌گیرم. تحقیق محرم انجام می‌شود. کارمند موقتاً از کار کنار حفظ می‌کنم و به هیچ کس اطلاع نمی‌دهم. فوراً به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم و با محرمانه

Sample Answer

First, I would maintain confidentiality and immediately report to the central office and the PSEA focal point. I would ensure the alleged perpetrator is temporarily suspended from duty pending investigation. I would ensure the survivor receives medical and psychosocial support. I would document all actions and ensure the investigation follows organizational policy. No decision would be made without a thorough and fair investigation.

۶.۱۲ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

نیاز = Recruitment → ToR → اعلان → Shortlisting → امتحان/مصاحبه → انتخاب.

• شرح وظایف = ToR

• رخصتی = Leave حاضری؛ = Attendance

• ارزیابی عملکرد = Performance

• روند اجراات - عادلانه و مستند = Disciplinary Process

• عدم تحمل مطلق + گزارش الزامی = PSEA

حمایت کن ← گزارش بده ← اصل طلایی PSEA: ببین

جواب‌های طلایی فصل ششم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
انجام می‌شود؟ Recruitment چطور	نیاز → ToR → اعلان → Shortlisting → مصاحبه → انتخاب	→ ToR → Need → Announcement → Interview → Shortlisting Selection.
چیست؟ ToR	شرح وظایف	Terms of Reference – job description.
متخلف باشد چه می‌کنی؟ اگر کارمند	بشنو، مطابق پالیسی اقدام کن تحقیق کن، دفاع	Investigate, hear their side, and act according to policy.
چیست؟ Confidentiality	حفظ محرمت معلومات	Keeping information confidential.
چیست؟ PSEA	استثمار و سوء استفاده جنسی حفاظت از	Protection from Sexual Exploitation and Abuse.
تخلف ببینی چه می‌کنی؟ اگر PSEA	بده – محرمت حفظ کن فوراً گزارش	Report immediately – maintain confidentiality.

نکته آخر فصل ششم

مدیریت کنی، خدمات بهتر می‌شود. PSEA = خط سرخ؛ هیچ استثنایی نیست.
کارمند = سرمایه سازمان. اگر تیم را درست

هفتم: هماهنگی و مدیریت Stakeholderها

فصل

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. Stakeholder های ولایتی را فهرست می‌کنی و نقش هرکدام را می‌دانی
۲. دفتر مرکزی و جامعه - هر کدام با زبان و روش خودش - هماهنگ می‌کنی. PPHD، MoPH،
۳. تعارض را می‌شناسی و آن را با شنیدن، بررسی و پیگیری حل می‌کنی.
۴. می‌دانی چه وقت و چطور مشکل را Escalate کنی.

چرا این فصل مهم است؟

کار کنی، نمی‌توانی Stakeholder هماهنگ‌کننده. اگر نتوانی با Coordinator = باشی Coordinator ها

ها کی‌ها اند؟ Stakeholder ۷.۱

مفهوم ساده

یعنی هر کسی که در کار تو تأثیر دارد یا از کار تو تأثیر می‌گیرد Stakeholder

Stakeholder	نقش
دفتر مرکزی (Central Office)	تصمیم‌گیری، بودجه، پالیسی
PPHD	صحت عامه ولایت - هماهنگی، نظارت ریاست
MoPH	وزارت صحت عامه - پالیسی، معیارها
های دیگر NGO	هماهنگی در ساحه
UN Agencies	دو نر، هماهنگی
شورای صهی	مشارکت جامعه
مراکز صهی	ارائه خدمات
مریضان	دریافت‌کنندگان خدمات

مثال از دایکندی

و دفتر مرکزی BHC، دایکندی، شفاخانه ولایتی PPHD: های تو شامل Stakeholder در کابل SO ها، شوراهای قریه

۷.۲ هماهنگی با PPHD

کنی؛ راپور SO را شریک کنی؛ مشکلات را مطرح کنی؛ از PPHD کمک بخواهی. تو باید: در جلسات PPHCC اشتراک

مثال از دایکندی

SO دایکندی هر ماه جلسه می‌کند. تو باید در آن اشتراک کنی و راپور PPHCC را ارائه بدهی - فعالیت‌ها، مشکلات، پلان‌ها

۷.۳ هماهنگی با MoPH

بدهند؛ MoPH کار کنند؛ راپور ربعوار به BPHS/EPHS ها باید؛ مطابق NGO سالانه ارائه دهند Audit.

مثال از دایکندی

باشد MoPH و PPHD در دایکندی باید راپور ربعوار فعالیت‌های صحتی را به SO کند. Audit می‌تواند MoPH، بفرستد. اگر مشکلی

۷.۴ هماهنگی با دفتر مرکزی

مشکلات را اطلاع بدهی؛ از آنها راهنمایی بخواهی؛ مطابق پالیسی کار کنی. تو باید؛ راپور منظم بفرستی؛

مثال از دایکندی

به دفتر مرکزی SO در کابل اطلاع می‌دهی. آنها تصمیم می‌گیرند که چه اقدام شود. اگر در دایکندی یک مشکل امنیتی بزرگ پیش بیاید، تو فوراً

۷.۵ هماهنگی با جامعه

کنی؛ مشکلات جامعه را بشنوی؛ خدمات را مطابق نیاز جامعه هماهنگ کنی. تو باید؛ با شورای صحتی جلسه

مثال از دایکندی

مشکل را می‌شنوی و با PPHD هماهنگ می‌کنی تا قابله جدید استخدام شود. مردم شکایت دارند که قابله در کلینیک نیست. تو با شورای قریه جلسه می‌کنی، در یک قریه در ولسوالی اشتراکی،

۷.۶ مدیریت تعارض (Conflict)

مفهوم ساده

که چطور مدیریت شود Conflict، یعنی اختلاف نظر یا دعوا. در محیط کار Conflict طبیعی است؛ مهم این است

نوع	مثال
بین کارمندان	دو کارمند با هم اختلاف دارند
بین سازمان و PPHD	اختلاف در اولویت‌ها
بین سازمان و جامعه	جامعه از خدمات راضی نیست

مثال از دایکندی

را بررسی می‌کنی و راه حل ارائه می‌دهی - مثلاً آموزش مجدد در ثبت معلومات. را اشتباه ثبت می‌کند. تو هر دو را جداگانه می‌بینی، مشکل را می‌شنوی، حقیقت دو کارمند در BHC نیلی با هم دعوا می‌کنند - یکی می‌گوید دیگری معلومات

برای امتحان

را خاموش نکن: بشنو، بررسی کن، حل کن، پیگیری کن Conflict

۷.۷ ارتباط (Communication)

مفهوم ساده

بدل کردن معلومات - کتبی، شفاهی، رسمی، غیررسمی: جلسه Communication. ایمیل، تماس تلفونی، جلسه غیررسمی، (Report) راپور، (Meeting) یعنی رد و

مثال از دایکندی

رسمی. بعد از جلسه، یک ایمیل تأییدی می‌فرستی - Communication کتبی. مشکل Stock-out دوا در BHC اشتراکی را مطرح می‌کنی - Communication تو با PPHD

حفظ کن

خوب = واضح + محترمانه + مستند Communication

۷.۸ تشدید (Escalation)

مفهوم ساده

یعنی بردن مشکل به سطح بالاتر - وقتی خودت نمی‌توانی حل کنی Escalation
کی Escalate کنی؟

- مشکل از توان تو بالاتر است
- مشکل فوری است و راه‌حل محلی ندارد
- مشکل امنیتی است
- مشکل مالی بزرگ است

مثال از دایکندی

نکرده. تو با تدارکات ولایتی پیگیری کردی - جواب نداد. حالا به دفتر مرکزی BHC
آنها با تدارکات مرکزی صحبت می‌کنند Escalate شهرستان ۲ ماه دوا دریافت
می‌کنی؛

برای امتحان

- وقتی لازم است، به سطح بالاتر برو. اما اول خودت تلاش کن Escalation =
بدون تلاش = ضعف Escalation

۷.۹ تمرین کوتاه

تمرین کوتاه

در کلینیک نیست و زنان نمی‌توانند به داکتر مرد مراجعه کنند. سؤال: چه می‌کنی؟
شورای قریه در ولسوالی کیتی شکایت دارد که داکتر زن

جواب مدل

است. به دفتر مرکزی راپور می‌دهم. پیگیری می‌کنم تا داکتر زن استخدام شود. داکتر زن موقت می‌فرستم. به شورای قریه اطلاع می‌دهم که اقدام در جریان می‌کنم تا داکتر زن جدید استخدام شود. اگر فوری باشد، از کلینیک نزدیک‌تر زن اصلاً استخدام شده؟ آیا رخصتی است؟ آیا استعفا داده؟ بعد با PPHD هماهنگی را دقیق می‌شنوم. بعد به کلینیک می‌روم و وضعیت را بررسی می‌کنم - آیا داکتر اول با شورای قریه جلسه می‌کنم و مشکل

Sample Answer

First, I would meet with the community shura to understand the issue. Then I would visit the facility to verify the situation. I would coordinate with PPHD to recruit a female doctor, arrange a temporary female doctor from a nearby facility if possible, inform the community about the action being taken, report to the central office, and follow up until the position is filled.

۷.۱۰ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

- هر کسی که در کار تأثیر دارد = Stakeholder
- ریاست صحت عامه ولایت - هماهنگی کن = PPHD
- وزارت صحت عامه - پالیسی و معیارها = MoPH
- دفتر مرکزی = مرکز تصمیم‌گیری SO.
- را بشنو، بررسی کن، حل کن Conflict
- وقتی لازم است، به سطح بالاتر برو = Escalation

مستند ← محترمانه ← اصل طلایی Communication: واضح

جواب‌های طلایی فصل هفتم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
--------------	------------------	-------------------------

Anyone who affects or is affected by the work.	کار تأثیر دارد یا تأثیر می‌گیرد هر کسی که در	کیست؟ Stakeholder
Provincial Public Health Directorate.	ریاست صحت عامه ولایت	چیست؟ PPHD
Listen, verify, resolve, and follow up.	کن، حل کن، پیگیری کن بشنو، بررسی	چطور حل می‌کنی؟ Conflict
When the issue is beyond your capacity.	مشکل از توان تو بالاتر است وقتی	کی می‌کنی؟ Escalation
Clear, respectful, and documented.	واضح، محترمانه، مستند	دارد؟ Communication خوب چه ویژگی
Meet with the shura, listen to issues, coordinate services.	مشکلات، هماهنگی خدمات جلسه با شورا، شنیدن	چطور هماهنگ می‌کنی؟ با جامعه

نکته آخر فصل هفتم

هماهنگ‌کننده؛ اگر نتوانی هماهنگ کنی، نمی‌توانی کار کنی = Coordinator
 PPHD → MoPH → دفتر مرکزی → جامعه - این زنجیر را حفظ کن.

سناریوهای واقعی Provincial Coordinator

فصل هشتم:

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. سناریوی واقعی کار Coordinator را می‌شناسی و برای هرکدام پلان اقدام داری.
۲. در هر سناریو، هفت کلمه طلایی را به کار می‌بری: بفهم ← بررسی کن ← بده اولویت ← اقدام کن ← مستند کن ← راپور بده ← پیگیری کن.
۳. جواب دری و انگلیسی هر سناریو را می‌توانی در امتحان و مصاحبه بازگو کنی.
۴. می‌دانی در بحران اول کدام کار را انجام بدهی.

چرا این فصل مهم است؟

دارد - با جواب مدل. قانون: در هر سناریو، هفت کلمه طلایی را به کار ببر: بفهم در امتحان و مصاحبه، سناریو می‌دهند. این فصل ۳۰ سناریوی واقعی ← کن بررسی ← اولویت بده ← اقدام کن ← مستند کن ← راپور بده ← پیگیری کن

سناریو ۱: Stock-out دوا در BHC نیلی

دوای اساسی (Amoxicillin و Paracetamol) تمام کرده؛ ۲۰ مریض در صف است. موقعیت: BHC نیلی

علت را پیدا می‌کنم. در راپور نظارت مستند می‌کنم. پیگیری می‌کنم تا دوا برسد. به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. Stock Card را چک می‌کنم - چرا تمام شده؟ از PPHD کمک می‌خواهم؛ اگر ممکن باشد از BHC نزدیک‌تر دوا قرض می‌گیرم؛ اولویت اول = حل فوری. با تدارکات ولایتی تماس می‌گیرم؛

Sample Answer

First, I would address the immediate need by contacting the provincial logistics team and requesting support from PPHD. If possible, I would arrange a loan from a nearby facility. I would inform the central office, investigate the root cause using the stock card, document the findings, and follow up until the medicine is replenished.

سناریو ۲: راپور HMIS ناقص

است - ۱۰ کلینیک راپور نفرستاده‌اند؛ امروز آخرین روز فرستادن به PPHD است. موقعیت: راپور HMIS ولایت ناقص

اگر ممکن باشد، راپور ناقص را با معلومات موجود می‌فرستم و به HMIS Officer تماس بگیرد و علت را بپرسد - مشکل تخنیک؟ نبود کارمند؟ مشکل امنیتی؟ می‌کنم که کلینیک‌ها راپور بفرستند PPHD را مسئول می‌کنم که فوراً با ۱۰ کلینیک راپور تکمیلی بعداً می‌آید. دلیل تأخیر و اقدام را در راپور ماه بعد می‌نویسم. پیگیری اطلاع می‌دهم که

Sample Answer

I would assign the HMIS Officer to immediately contact the 10 facilities, identify the reasons for delay, and collect the reports. If necessary, I would submit a partial report to PPHD and communicate that the complete report will follow. I would document the reasons and actions taken, and follow up to ensure all facilities submit their reports.

سناریو ۳: مریض TB ثبت نمی‌شود

HMIS نشان می‌دهد BHC نیلی صفر مریض TB دارد - سال گذشته ۱۵ مریض بود. موقعیت: راپور

به PPHD اطلاع می‌دهم؛ در راپور نظارت مستند می‌کنم؛ هفته بعد پیگیری می‌کنم. کلینیک هدایت می‌دهم که ثبت را اصلاح کند؛ اگر لازم باشد آموزش کوتاه می‌دهم. می‌کنم: آیا ثبت نمی‌شود یا واقعاً مریض نیست؟ اگر ثبت نمی‌شود، به مسئول Register TB مراجعه می‌کنم؛ با مسئول TB صحبت

Sample Answer

I would verify the data against the TB register and discuss with the TB focal point. If it is a recording issue, I would provide on-the-job feedback, ensure corrective action is taken, report to PPHD, and follow up to confirm accurate data in the next reporting period.

سناریو ۴: قابله استعفا می‌دهد

موقعیت: قابله BHC نیلی استعفا می‌دهد؛ ولادت‌ها متوقف می‌شود.

است. به دفتر مرکزی راپور می‌دهم. پیگیری می‌کنم تا قابله جدید استخدام شود. نزدیک‌تر قابله موقت می‌فرستم. به شورای قریه اطلاع می‌دهم که اقدام در جریان به PPHD اطلاع می‌دهم و درخواست قابله جدید می‌کنم. اگر ممکن باشد، از BHC اول علت استعفا را می‌پرسم - آیا قابل حل است؟ اگر نه، فوراً

Sample Answer

First, I would understand the reason for resignation. If not resolvable, I would immediately inform PPHD and request a replacement. I would arrange a temporary midwife from a nearby facility if possible, inform the community, report to the central office, and follow up until a new midwife is recruited.

سناریو ۵: مشکل امنیتی در راه

موقعیت: در راه BHC اشتراکی مشکل امنیتی است؛ نمی‌توانی نظارت بروی.

(تلیفون، راپور کتبی) معلومات جمع کن. اگر مشکل بزرگ باشد، Escalate کن. بگیر. به PPHD و دفتر مرکزی اطلاع بده. نظارت را به تعویق بینداز. از راه‌های دیگر اول امنیت خودت و تیم را در نظر

Sample Answer

First, I would prioritize safety. I would inform PPHD and the central office, postpone the visit, and use alternative methods such as phone calls and written reports to collect information. If the issue is significant, I would escalate it to the central office.

سناریو ۶: دوا در زمستان گیر می‌کند

در ماه قوس، دوا برای BHC اشتراکی نفرستاده شده؛ راه‌ها در حال بسته شدن است. موقعیت:

مرکزی اطلاع می‌دهم. از تجربه درس می‌گیرم - باید از ماه میزان شروع می‌کردم. است، باید فوراً فرستاده شود؛ اگر ممکن نباشد، از PPHD کمک می‌خواهم. به دفتر فوراً با تدارکات تماس می‌گیرم. اگر دوا موجود

Sample Answer

I would immediately contact logistics to send the medicine urgently. If not possible, I would request support from PPHD. I would inform the central office and document the lesson learned: winterization planning must start in Mizan, not Qaws.

سناریو ۷: کارمند بدون اجازه غایب

موقعیت: یک کارمند BHC نیلی ۳ روز بدون اجازه غایب است.

می‌دهم. اگر تکرار شود، به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. در فایل کارمند ثبت می‌کنم. حاضری را چک می‌کنم؛ با کارمند صحبت می‌کنم. اگر دلیل موجه نباشد، تذکر کتبی

Sample Answer

I would check attendance records, discuss with the employee, and if the absence is unjustified, issue a written warning. If repeated, I would escalate to the central office and document it in the employee's file.

سناریو ۸: شورای قریه شکایت دارد

موقعیت: شورای قریه در کیتی شکایت دارد که خدمات کلینیک ضعیف است. هماهنگ می‌کنم؛ به شورا اطلاع می‌دهم که اقدام در جریان است؛ پیگیری می‌کنم. به کلینیک می‌روم و وضعیت را بررسی می‌کنم. اگر مشکل واقعی است، با PPHD با شورا جلسه می‌کنم؛ شکایت را دقیق می‌شنوم؛

Sample Answer

I would meet with the shura, listen to their concerns, visit the facility to verify, coordinate with PPHD for corrective action, inform the community, and follow up.

سناریو ۹: دو مشکل همزمان - دوا و راپور

دوا در نیلی تمام شده؛ همزمان HMIS Officer می‌گوید راپور امروز آخرین روز است. موقعیت: صبح تماس می‌گیرند: کند؛ خودم مشکل دوا را حل می‌کنم. بعد از حل دوا، پیگیری راپور را چک می‌کنم. اولویت اول = دوا (زندگی مردم). HMIS Officer را مسئول می‌کنم راپور را جمع

Sample Answer

I would prioritize the medicine stock-out because patient lives are at risk. I would assign the HMIS Officer to collect the report while I address the medicine issue. After resolving the stock-out, I would follow up on the report.

سناریو ۱۰: PPHD در جلسه سخت‌گیری می‌کند

در جلسه PPHCC، رئیس PPHD از SO شکایت دارد که راپور دیر می‌فرستد. موقعیت:

در جلسه خاموش نمی‌نشینم - مشکل را واضح می‌گویم و راه‌حل پیشنهاد می‌کنم. می‌کنم - آموزش کارمند موجود. تعهد می‌دهم که ماه بعد راپور به‌موقع برسد. را توضیح می‌دهم - نبود کارمند HMIS در یک ولسوالی. اقدام اصلاحی پیشنهاد عذر می‌خواهم و علت

Sample Answer

I would apologize, explain the reason (lack of HMIS staff in one district), propose corrective action (training existing staff), and commit to timely reporting next month. I would not remain silent – I would clearly present the issue and propose a solution.

سناریو ۱۱: دوا منقضی می‌شود

نشان می‌دهد ۱۰۰ دانه Amoxicillin در BHC نیلی در ماه جوزا منقضی می‌شود. موقعیت: Stock Card

کلینیک هدایت می‌دهم که موجودی را به‌روز نگه دارد. در راپور مستند می‌کنم. باشد، دوا را قبل از انقضا مصرف می‌کنم یا به مرکز دیگر می‌فرستم. به مسئول موجودی و تاریخ انقضا را چک می‌کنم. اگر ممکن

Sample Answer

I would check stock and expiry dates. If possible, I would redistribute the medicine before expiry. I would instruct the facility to maintain accurate stock records and document the action taken.

سناریو ۱۲: استخدام قابله – مشکل Shortlisting

برای وظیفه قابله در نیلی، ۲۰ CV می‌رسد؛ فقط ۳ نفر واجد شرایط هستند. موقعیت:

باشد، اعلان را دوباره نشر می‌کنم. اگر فوری باشد، از ToR را مطابق Shortlisting NGO یا PPHD انجام می‌دهم و ۳ نفر واجد شرایط را انتخاب می‌کنم. اگر تعداد کم دیگر کمک می‌خواهم

Sample Answer

I would conduct shortlisting according to the ToR, select the 3 qualified candidates, and if the number is insufficient, re-advertise. If urgent, I would request support from PPHD or another NGO.

سناریو ۱۳: تصفیه Advance دیر می‌شود

یک کارمند Advance گرفته برای سفر نظارتی؛ ۲ هفته گذشته و تصفیه نکرده. موقعیت:

صحبت می‌کنم. مطابق پالیسی، Advance باید در زمان مشخص تصفیه شود. اگر اسناد ندارد، کمک می‌کنم جمع کند. اگر مشکل مالی دارد، با دفتر مرکزی با کارمند صحبت می‌کنم و علت تأخیر را می‌پرسم.

Sample Answer

I would discuss with the employee to understand the delay. If documents are missing, I would help collect them. If there is a financial issue, I would consult the central office. According to policy, advances must be cleared within the specified timeframe.

سناریو ۱۴: Audit می‌آید

یک شرکت Audit خارجی می‌آید و اسناد مالی دفتر ولایتی را بررسی می‌کند. موقعیت:

دارد، صادقانه جواب می‌دهم. اگر مشکلی باشد، فوراً به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. تصفیه Advance ها، راپورها. با تیم مالی هماهنگ می‌کنم. هر سؤالی که Audit تمام اسناد مالی را آماده می‌کنم - فاکتورها، رسیدها،

Sample Answer

I would ensure all financial documents are ready - invoices, receipts, advance clearances, and reports. I would coordinate with the finance team, answer audit questions honestly, and immediately inform the central office of any issues.

سناریو ۱۵: زمستان - آمادگی

موقعیت: در ماه میزان هستی؛ باید برای زمستان آماده شوی.

ذخیره احتیاطی می‌سازم؛ به PPHD اطلاع می‌دهم؛ پلان زمستانی می‌نویسم. آماده می‌کنم؛ سوخت و گرمی‌کننده تهیه می‌کنم؛ با تدارکات هماهنگ می‌کنم؛ دوا و تجهیزات را برای BHC‌های دورافتاده

Sample Answer

I would prepare medicines and supplies for remote facilities, arrange fuel and heating, coordinate with logistics, build safety stock, inform PPHD, and document a winterization plan.

سناریو ۱۶: مریض شکایت دارد

موقعیت: یک مریض شکایت دارد که در BHC نیلی بد رفتاری شده.

اقدام می‌کنم؛ به مریض اطلاع می‌دهم که پیگیری می‌شود؛ در راپور مستند می‌کنم. کلینیک صحبت می‌کنم؛ حقیقت را بررسی می‌کنم. اگر تخلف باشد، مطابق پالیسی شکایت را می‌شنوم؛ محرمت حفظ می‌کنم؛ با مسئول

Sample Answer

I would listen to the complaint, maintain confidentiality, discuss with the facility in-charge, verify the facts, take action according to policy, inform the patient, and document the case.

سناریو ۱۷: HMIS Reporting Rate پایین

موقعیت: Reporting Rate ولایت ۷۰٪ است؛ باید بالا برود.

امنیتی است، به PPHD اطلاع می‌دهم. پلان Action می‌سازم و پیگیری می‌کنم. است، کمک تخنیکی می‌کنم؛ اگر نبود کارمند است، آموزش می‌دهم؛ اگر مشکل علت را پیدا می‌کنم - کدام کلینیک‌ها نفرستاده‌اند و چرا؟ اگر مشکل تخنیکی

Sample Answer

I would identify which facilities are not reporting and why. If it is a technical issue, I would provide technical support. If it is a staffing issue, I would provide training. If it is a security issue, I would inform PPHD. I would create an action plan and follow up.

سناریو ۱۸: موتر خراب می‌شود

موقعیت: موتر دفتر ولایتی برای نظارت خراب شده؛ سفر نظارتی فردا است. نه، به تعویق می‌اندازم و به کلینیک اطلاع می‌دهم. به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. هماهنگ کنم؟ سفر را به تعویق بیندازم؟ اگر سفر فوری باشد، کرایه می‌کنم؛ اگر گزینه‌ها را بررسی می‌کنم: موتر کرایه کنم؟ با PPHD

Sample Answer

I would explore options: rent a vehicle, coordinate with PPHD, or postpone. If urgent, I would rent. If not, I would reschedule and inform the facility and central office.

سناریو ۱۹: دو کارمند با هم دعوا می‌کنند

موقعیت: دو کارمند در BHC نیلی با هم دعوا می‌کنند. ارائه می‌دهم. اگر لازم باشد، به دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. در راپور مستند می‌کنم. هر دو را جداگانه می‌بینم؛ مشکل را می‌شنوم؛ حقیقت را بررسی می‌کنم؛ راه‌حل

Sample Answer

I would meet with each employee separately, listen to both sides, verify the facts, provide a solution, inform the central office if necessary, and document the case.

سناریو ۲۰: PPHD درخواست معلومات فوری دارد

PPHD می‌خواهد معلومات فوری در مورد یک کلینیک بدهی؛ تو در ساحه هستی. موقعیت:

اگر نتوانم فوراً جمع کنم، به PPHD اطلاع می‌دهم که تا چند ساعت دیگر می‌فرستم. با کلینیک تماس می‌گیرم؛ معلومات را جمع می‌کنم؛ به PPHD می‌فرستم.

Sample Answer

I would contact the facility, collect the information, and send it to PPHD. If I cannot collect it immediately, I would inform PPHD of a realistic timeline.

سناریو ۲۱: دوا در راه گم می‌شود

موقعیت: دوا برای BHC اشتراکی فرستاده شد، اما به مقصد نرسید.

اطلاع می‌دهم؛ دواي جديد درخواست می‌کنم؛ در راپور حادثه‌ای مستند می‌کنم. تماس می‌گیرم و پیگیری می‌کنم دوا کجاست. اگر گم شده، به PPHD و دفتر مرکزی با تدارکات و ترانسپورت

Sample Answer

I would contact logistics and transport to trace the shipment. If lost, I would inform PPHD and the central office, request replacement, and document an incident report.

سناریو ۲۲: کارمند جدید آموزش می‌خواهد

موقعیت: یک کارمند جدید HMIS استخدام شده؛ آموزش ندارد.

ترتیب می‌دهم. خودم هم آموزش اولیه می‌دهم. پیگیری می‌کنم که آموزش دیده. را با PPHD یا دفتر مرکزی هماهنگ می‌کنم. اگر ممکن باشد، آموزش آنلاین DHIS2 آموزش

Sample Answer

I would coordinate training with PPHD or the central office. If possible, I would arrange DHIS2 online training. I would also provide basic orientation and follow up to ensure training is completed.

سناریو ۲۳: دواى منقضى - دفع

Stock Card نشان می‌دهد ۵۰ دانه دواى منقضى در BHC نیلی موجود است. موقعیت:

اطلاع می‌دهم. علت انقضا را بررسی می‌کنم - آیا مصرف کم بوده یا سفارش زیاد؟ جدا می‌کنم؛ مطابق طرزالعمل دفع می‌کنم؛ در Stock Card ثبت می‌کنم؛ به PPHD دواى منقضى را

Sample Answer

I would separate expired medicines, dispose of them according to procedure, record it in the stock card, inform PPHD, and investigate the cause (low consumption or over-ordering).

سناریو ۲۴: مریض بحرانی - ارجاع

یک مریض بحرانی در BHC نیلی است؛ باید به شفاخانه ولایتی ارجاع شود. موقعیت:

می‌کنم؛ اگر ترانسپورت لازم باشد، ترتیب می‌دهم؛ در Register ثبت می‌کنم. را هدایت می‌کنم که مریض را برای ارجاع آماده کند؛ با شفاخانه ولایتی هماهنگ مسئول کلینیک

Sample Answer

I would instruct the facility to prepare the patient for referral, coordinate with the provincial hospital, arrange transport if needed, and document it in the register.

سناریو ۲۵: راپور ماهوار - آمار اشتباه

دارد - تعداد مریضان OPD ۵۰۰ نوشته شده، اما Register ۳۵۰ نشان می‌دهد. موقعیت: راپور ماهوار یک کلینیک آمار اشتباه می‌کنم؛ به HMIS Officer اطلاع می‌دهم؛ آموزش مجدد می‌دهم؛ پیگیری می‌کنم. و تفاوت را توضیح می‌دهم؛ Register را چک می‌کنم؛ اگر آمار اشتباه است، اصلاح با مسئول کلینیک تماس می‌گیرم

Sample Answer

I would contact the facility, explain the discrepancy, verify the register, correct the report, inform the HMIS Officer, provide refresher training, and follow up.

سناریو ۲۶: بودجه تمام می‌شود

موقعیت: بودجه ماهانه تمام شده، اما یک فعالیت مهم باقی مانده. بودجه اضافی می‌کنم؛ اگر نه، به ماه بعد موکول می‌کنم. در راپور مستند می‌کنم. بررسی می‌کنم - آیا فعالیت فوری است؟ اگر فوری است، از دفتر مرکزی درخواست اولویت را

Sample Answer

I would assess the priority. If urgent, I would request additional budget from the central office. If not, I would postpone to next month and document it.

سناریو ۲۷: کارمند PSEA تخلف می‌کند

موقعیت: یک کارمند متهم به رفتار نادرست با یک مریض زن شده. روانی و صحت می‌شود؛ تحقیق محرم انجام می‌شود؛ مطابق پالیسی اقدام می‌شود. PSEA اطلاع می‌دهم؛ کارمند موقتاً از کار کنار گذاشته می‌شود؛ مریض حمایت محرمیت حفظ می‌کنم؛ فوراً به دفتر مرکزی و مسئول

Sample Answer

I would maintain confidentiality, immediately report to the central office and PSEA focal point, suspend the employee pending investigation, ensure the survivor receives support, and follow policy for investigation and action.

سناریو ۲۸: شورای قریه نمی‌خواهد واکسین بزند

موقعیت: شورای قریه در یک ولسوالی مخالف واکسین است.

می‌خواهم؛ اگر لازم باشد، از PPHD کارمند آگاهی‌دهی می‌فرستم؛ پیگیری می‌کنم. می‌شنوم؛ معلومات درست در مورد واکسین می‌دهم؛ از بزرگان و علمای قریه کمک با شورا جلسه می‌کنم؛ نگرانی‌شان را

Sample Answer

I would meet with the shura, listen to their concerns, provide accurate information about vaccination, engage community elders and religious leaders, request health education support from PPHD if needed, and follow up.

سناریو ۲۹: زلزله – پاسخ فوری

موقعیت: در دایکندی زلزله شده؛ مراکز صحت آسیب دیده.

دوا و تجهیزات فوری می‌فرستم؛ در راپور حادثه‌ای مستند می‌کنم؛ پیگیری می‌کنم. مراکز صحت را ارزیابی می‌کنم؛ اگر آسیب دیده، خدمات موقت ترتیب می‌دهم؛ فوراً به دفتر مرکزی و PPHD اطلاع می‌دهم؛ وضعیت

Sample Answer

I would immediately inform the central office and PPHD, assess the situation, arrange temporary services if damaged, dispatch emergency supplies, document an incident report, and follow up.

سناریو ۳۰: Coordinator جدید - انتقال وظیفه

تو Coordinator جدید هستی؛ باید از Coordinator قبلی وظیفه را تحویل بگیری. موقعیت:

صحی؛ جلسه با PPHD؛ جلسه با تیم؛ شناسایی مشکلات فوری؛ پلان کاری ۳۰ روزه. تمام اسناد - راپورها، Stock Cards، فایل‌های HR، اسناد مالی؛ بازدید از مراکز ملاقات با Coordinator قبلی؛ گرفتن

Sample Answer

I would meet with the outgoing coordinator, collect all documents (reports, stock cards, HR files, financial records), visit health facilities, meet with PPHD and the team, identify urgent issues, and create a 30-day work plan.

۸.۳۱ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

- در هر سناریو، اولویت اول = زندگی مردم.
- فوراً حل کن، علت را پیدا کن، پیگیری کن = Stock-out.
- ناقص = علت را پیدا کن، جمع کن، پیگیری کن HMIS.
- مشکل HR = عادلانه، مستند، مطابق پالیسی.
- مشکل مالی = علت را پیدا کن، با دفتر مرکزی صحبت کن.
- عدم تحمل مطلق + گزارش الزامی = PSEA.

← اقدام کن ← اولویت بده ← بررسی کن ← هفت کلمه طلایی در هر سناریو: بفهم پیگیری کن ← راپور بده ← مستند کن

جواب‌های طلایی فصل هشتم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
چطور حل می‌کنی؟ Stock-out	علت را پیدا کن، پیگیری کن فوراً حل کن،	Solve immediately, find the cause, and follow up.

Identify the cause, collect, and follow up.	پیدا کن، جمع کن، پیگیری کن علت را	چطور حل می‌کنی؟ HMIS ناقص
Maintain confidentiality, report, and investigate.	کن، گزارش بده، تحقیق کن محرمت حفظ	چطور مدیریت می‌کنی؟ PSEA تخلف
Prioritize – patient lives first.	اولویت بده – زندگی مردم اول	اگر دو مشکل همزمان باشد؟
When the issue is beyond your capacity.	مشکل از توان تو بالاتر است وقتی	کی می‌کنی؟ Escalation
Collect, report, and follow up.	کن، راپور بده، پیگیری کن جمع	ناقص چطور حل می‌کنی؟ راپور

نکته آخر فصل هشتم

در امتحان، سناریو می‌دهند - هفت کلمه طلایی را به کار ببر: بفهم ← بررسی کن ←
اولویت بده ← اقدام کن ← مستند کن ← راپور بده ← پیگیری کن

نهم: Shuhada Organization را بشناس

فصل

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

تاریخچه، مأموریت، ارزش‌ها و ساختار Shuhada Organization را توضیح می‌دهی.

۱.

۲. فعالیت‌های صحی SO در دایکندی را می‌شناسی.

۳. مسئولیت‌های این بست را در ساختار SO جای می‌دهی.

۴. برای پرسش‌های مصاحبه در باره SO، جواب آماده داری.

چرا این فصل مهم است؟

توجه: این فصل فقط معلومات تأییدشده از منابع رسمی SO را شامل می‌شود.

در مصاحبه، از SO می‌پرسند. اگر شناسی، نمی‌توانی جواب بدهی.

۹.۱ تاریخچه

مفهوم ساده

آن شفاخانه‌ای برای زنان و اطفال افغان پناهنده بود (SO) Shuhada Organization سال ۱۹۸۹ توسط داکتر سیما سمر در کوئته، پاکستان بنیان گذاشته شد؛ اولین مرکز در.

چرا تأسیس شد؟

افغان را حل کند. در آن زمان، زنان افغان به خدمات صحتی دسترسی نداشتند؛ SO تأسیس شد تا عدم وجود کامل مراقبت‌های صحتی باروری برای زنان و اطفال. برای آنها شفاخانه و مکتب ساخت

توسعه:

توانمندسازی اقتصادی زنان، حفاظت از اطفال، حقوق بشر و ظرفیت‌سازی. فعالیت‌های SO به بخش‌های دیگر گسترش یافت: آموزش، کمک‌های بشردوستانه، بعد از تأسیس،

ولایات تحت پوشش:

افغانستان - از جمله دایکندی، بامیان، غزنی، غور، وردک و کابل - فعالیت دارد SO در ولایات مرکزی و همجوار

دستاوردها

طفل حمایت شده‌اند • مجموع: ۶.۳ میلیون نفر از پروژه‌های SO مستفید شده‌اند
شده‌اند • ۷,۶۳۴ نفر از توانمندسازی اقتصادی زنان مستفید شده‌اند • ۳۸۷
از کمک‌های بشردوستانه مستفید شده‌اند • ۳۰,۹۲۱ نفر از ظرفیت‌سازی مستفید
شده‌اند • ۱.۵ میلیون نفر از خدمات حقوق بشر مستفید شده‌اند • ۲۲۶,۰۳۸ نفر
• ۵.۸ میلیون نفر از خدمات صحتی مستفید

۹.۲ مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها

مأموریت (Mission):

شعار مشترک SO: Working for a better tomorrow - کار برای فردای بهتر.
با کیفیت خوب در بخش‌های صحت، آموزش و توانمندسازی اقتصادی زنان.
«ارائه خدمات»

چشم‌انداز (Vision):

بالا مطابق اصول حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، صلح و عدم تبعیض SO «جامعه آگاه، مرفه و صحت در افغانستان ببیند - از طریق ارائه خدمات با کیفیت می‌خواهد یک»

ارزش‌ها (Values):

- پاسخگویی (Accountability) • حساسیت جنسیتی (Gender Sensitivity)
- شفافیت (Transparency)
- حرفه‌ای بودن (Professionalism) • تعالی (Excellence)

حفظ کن

ارزش‌ها: شفافیت، پاسخگویی، حساسیت جنسیتی، حرفه‌ای بودن، تعالی
 صحت، آموزش، توانمندسازی زنان | شعار: Working for a better tomorrow
 مأموریت:

۹.۳ ساختار سازمانی

یک ساختار دموکراتیک دارد SO

نقش	نهاد
تصمیم‌گیری عالی	Board of Directors (BoD)
مدیریت اجرایی	Management Board
مدیر اجرایی عمومی	General Executive Director
اجرای پروژه‌ها در ولایات	دفاتر ولایتی

چهار دپارتمان عملی دارد SO

- صحت (Health) • آموزش (Education)
- کمک‌های بشردوستانه (Humanitarian Aid)
- توانمندسازی اقتصادی زنان (Women Economic Empowerment)

۹.۴ فعالیت‌های ص‌ی SO در دایکندی

فعال است - به شمول ولسوالی‌های نیلی، اشت‌رلی، شهرستان و کیتی SO در دایکندی.

پروژه‌های اخیر در دایکندی:

- شهرستان - با هزینه ۳۵,۰۰۰ دالر، با مشارکت جامعه (۲۵,۰۰۰ دالر از جامعه) مرکز ص‌ی چ‌چن (Chuchan Health Center) در ولسوالی
- در سال ۲۰۲۳ با حمایت مالی HCS (Help Committee Schaffhausen) مرکز ص‌ی کورگا (Korga Health Sub-Center) در ولسوالی اشت‌رلی - افتتاح
-
- مرکز ص‌ی شیلان کورگا در ولسوالی اشت‌رلی - با هزینه ۴۰,۰۰۰ دالر

مثال از دایکندی

ک‌نی و با Coordinator دارد. تو Health Post و BHC در دایکندی مراکز ص‌ی SO ک‌نی PPHD این مراکز هستی: باید نظارت ک‌نی، راپور بگیری، مشکلات را حل هماهنگ.

۹.۵ فرهنگ سازمانی SO

غیرانتفاعی، غیرسیاسی و مستقل است. فرهنگ سازمانی آن شامل SO: یک سازمان غیردولتی،

- تعهد به کیفیت: خدمات با کیفیت بالا
- تمرکز بر زنان و اطفال: اولویت اصلی
- مشارکت جامعه: جامعه در پروژه‌ها شریک است
- هماهنگی با حکومت: کار با MoPH و PPHD
- پاسخگویی: راپور منظم به MoPH و دونرها

مثال از دایکندی

۲۵,۰۰۰ دالر کمک کرد. این نشان می‌دهد که SO به مشارکت جامعه باور دارد. در پروژه مرکز ص‌ی چ‌چن، جامعه

۹.۶ مسئولیت‌های این بست (Provincial Coordinator)

شرح	مسئولیت
اطمینان از تطبیق مطابق پلان	نظارت بر پروژه‌های SO
جلسات، راپور، پیگیری	هماهنگی با PPHD
حاضری، عملکرد، HR	مدیریت تیم ولایتی
ماهوار، ربعوار	راپوردهی به دفتر مرکزی
پیگیری دوا، بودجه	مدیریت تدارکات و مالی
شوراها، بزرگان	ارتباط با جامعه
رعایت اصول PSEA	حفاظت از PSEA

مثال از دایکندی

می‌خواهد؛ جامعه از تو خدمات می‌خواهد. تو همه این‌ها را هماهنگ می‌کنی. PPHD دایکندی از تو راپور فعالیت‌ها می‌خواهد؛ تیم ولایتی از تو راهنمایی دفتر مرکزی SO در کابل از تو راپور ماهوار می‌خواهد؛

۹.۷ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

- در ۱۹۸۹ توسط داکتر سیما سمر بنیان گذاشته شد SO
 - مأموریت: صحت، آموزش، توانمندسازی زنان.
 - شعار: Working for a better tomorrow.
 - ارزش‌ها: شفافیت، پاسخگویی، حساسیت جنسیتی، حرفه‌ای بودن، تعالی.
 - در دایکندی، بامیان، غزنی و کابل فعال است SO
 - در ولایت - هماهنگی، نظارت، راپوردهی SO نماینده = Coordinator
- جملات طلایی برای مصاحبه

صحت، آموزش و توانمندسازی زنان تمرکز دارد.» * «من به ارزش‌های SO» * پاسخگویی و حساسیت جنسیتی – باور دارم – SO در ۱۹۸۹ تأسیس شده و بر و جامعه، PPHD، حلقه وصل بین دفتر مرکزی = Coordinator» * «شفافیت، کلینیک‌ها»

جواب‌های طلایی فصل نهم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
کی تأسیس شد؟ SO	– توسط داکتر سیما سمر ۱۹۸۹	۱۹۸۹, founded by Dr. Sima Samar.
مأموریت SO چیست؟	آموزش، توانمندسازی زنان صحت،	Health, education, and women economic empowerment.
شعار SO چیست؟	Working for a better tomorrow	Working for a better tomorrow.
ارزش‌های SO چیست؟	جنسیتی، حرفه‌ای‌بودن، تعالی پاسخگویی، حساسیت شفافیت،	Transparency, accountability, gender sensitivity, professionalism, excellence.
کدام ولایات فعال است؟ SO در	غزنی، غور، وردک و کابل دایکندی، بامیان،	Daykundi, Bamyan, Ghazni, Ghor, Wardak and Kabul.
دارد؟ SO Coordinator چه مسئولیتی	راپوردهی، مدیریت تیم هماهنگی، نظارت،	Coordination, monitoring, reporting, team management.

نکته آخر فصل نهم

ارزش‌های SO سازمان صحت، آموزش و توانمندسازی زنان. تو نماینده SO = را در کارت نشان بده SO در دایکندی هستی؛

دهم: شبیه‌سازی کامل امتحان و مصاحبه فصل

اهداف این فصل

پس از خواندن این فصل:

۱. سه آزمون آزمایشی کامل را با وقت‌گیری حل می‌کنی.
۲. جواب‌های نمونه دري و انگلیسی را با جواب‌های خودت مقایسه می‌کنی.
- در مصاحبه، خودت را معرفی می‌کنی و برای سؤال‌های سناریویی و PSEA آماده‌ای.
- ۳.
۴. نقاط ضعف خودت را می‌شناسی و همان بخش کتاب را دوباره می‌خوانی.

چرا این فصل مهم است؟

Mock کامل دارد. اگر این سه را تمرین کنی، برای امتحان واقعی آماده‌ای.
این فصل سه Exam

آزمون آزمایشی ۱

بخش الف: سؤالات چند گزینه‌ای (۱۰) – MCQ سؤال

اولویت اول در کار چیست؟ ۱. Coordinator

الف) راپوردهی به دفتر مرکزی

• ب) جلسات PPHD

• ج) زندگی مردم و تداوم خدمات اساسی

• د) تدارکات

جواب: ج

چه فرق دارد؟ ۲. Risk با Issue

الف) Risk قبلاً اتفاق افتاده، Issue ممکن است بیفتد

• ب) Risk ممکن است بیفتد، Issue قبلاً اتفاق افتاده

• (ج) هر دو يك چيز هستند

• (د) Risk مالی است، Issue صحي

جواب: ب

چيست؟ AMC ۳.

Average Monthly Consumption (الف)

• (ب) Annual Medical Cost

• (ج) Afghanistan Medical Council

• (د) Advanced Management Course

جواب: الف

چطور محاسبه می‌شود؟ Reorder Point ۴.

الف) AMC + زمان تحويل

• (ب) AMC زمان تحويل + ذخيره احتياطي

• (ج) موجودی مصرف

• (د) AMC ۲

جواب: ب

بايد چقدر باشد؟ HMIS Reporting Rate ۵.

الف) ۵۰%

• (ب) ۷۰%

• (ج) بالای ۹۵%

• (د) ۱۰۰%

جواب: ج

چيست؟ Variance ۶.

Planned + Actual (الف)

• (ب) Planned - Actual

• (ج) Actual Planned

• (د) Actual Planned

جواب: ب

چند اصل اساسی دارد؟ PSEA ۷.

الف) ۳

ب) ۴

ج) ۵

د) ۶

جواب: د

کی تأسیس شد؟ SO ۸.

الف) ۱۹۷۹

ب) ۱۹۸۹

ج) ۲۰۰۱

د) ۲۰۰۵

جواب: ب

چه خدماتی ارائه می‌دهد؟ BPHS ۹.

الف) خدمات شفاخانه‌ای

ب) خدمات صحت اولیه

ج) خدمات تخصصی

د) خدمات جراحی

جواب: ب

کی باید فرستاده شود؟ Incident Report ۱۰.

الف) یک هفته بعد

ب) یک ماه بعد

ج) همان روز

د) در راپور ماهوار

جواب: ج

بخش ب: سؤالات کوتاه - ۵ سؤال

۱. Work Plan؟ خوب چه ویژگی دارد؟

جواب: واضح، قابل اندازه‌گیری، مسئول مشخص، زمان مشخص.

۲. Monitoring با Evaluation؟ چه فرق دارد؟

جواب: Monitoring در جریان کار است؛ Evaluation بعد از تمام شدن.

۳. Executive Summary؟ چطور بنویسی؟

جواب: نتیجه اول، توضیح بعد - نصف صفحه.

۴. Supporting Documents؟ چیست؟

فاکتور، رسید، قرارداد - اسنادی که ثابت می‌کند پول درست مصرف شده.
جواب:

۵. Escalation؟ کی می‌کنی؟

جواب: وقتی مشکل از توان تو بالاتر است.

بخش ج: سناریو - ۱ سؤال

تمرین کوتاه

در ماه گذشته صفر مریض TB داشته - سال گذشته ۱۵ مریض بود. چه می‌کنی؟
تو Coordinator ولایت دایکندی هستی. راپور HMIS نشان می‌دهد که BHC نیلی

جواب مدل

به PPHD اطلاع می‌دهم؛ در راپور نظارت مستند می‌کنم؛ هفته بعد پیگیری می‌کنم.
به مسئول کلینیک هدایت می‌دهم که ثبت را اصلاح کند؛ آموزش کوتاه می‌دهم؛
TB صحبت می‌کنم - آیا ثبت نمی‌شود یا واقعاً مریض نیست؟ اگر ثبت نمی‌شود،
اول با Register TB مراجعه می‌کنم؛ با مسئول

Sample Answer

First, I would verify the data against the TB register. I would discuss with the TB focal point to determine if it is a recording issue. If so, I would provide on-the-job feedback, ensure corrective action, document findings, report to PPHD, and follow up.

بخش د: محاسبه - ۱ سؤال

زمان تحویل = ۱ ماه؛ ذخیره احتیاطی = ۲ ماه. Reorder Point چقدر است؟
محاسبه. AMC یک دوا ۲۰۰ دانه است؛

جواب: $600 = 200 + 400$ Reorder Point دانه

آزمون آزمایشی ۲

بخش الف: ۱۰ - MCQ سؤال

۱. BPHS کی ساخته شد؟

الف) ۱۹۸۹

ب) ۲۰۰۱

ج) ۲۰۰۳

د) ۲۰۰۵

جواب: ج

۲. DHIS2 چیست؟

الف) سیستم مالی

ب) سیستم معلومات صحی دیجیتال

ج) سیستم HR

د) سیستم تدارکات

جواب: ب

۳. Advance کی تصفیه شود؟

الف) هر وقت

• ب) در زمان مشخص

• ج) بعد از یک سال

• د) تصفیه لازم نیست

جواب: ب

۴. شعار SO چیست؟

الف) Health for All

• ب) Working for a better tomorrow

• ج) Together We Can

• د) Hope for Afghanistan

جواب: ب

۵. اصل اول چیست؟ PSEA

الف) محرمیت

• ب) عدم تحمل مطلق

• ج) گزارش الزامی

• د) حمایت از قربانی

جواب: ب

۶. چیست؟ Stock Card

الف) کارت بانکی

• ب) کارت ثبت موجودی دوا

• ج) کارت حاضری

• د) کارت مریض

جواب: ب

۷. چیست؟ PPHCC

الف) یک NGO

• (ب) کمیته هماهنگی صحتی ولایت

• (ج) یک شفاخانه

• (د) یک برنامه MoPH

جواب: ب

۸. Physical Count چیست؟

الف) شمارش فزیکتی موجودی

• (ب) شمارش مریضان

• (ج) شمارش کارمندان

• (د) شمارش پول

جواب: الف

۹. Coordinator می‌دهد؟

الف) فقط PPHD

• (ب) فقط دفتر مرکزی

• (ج) PPHD و دفتر مرکزی

• (د) فقط جامعه

جواب: ج

۱۰. Winterization می‌شود؟

الف) قوس

• (ب) جدی

• (ج) میزان

• (د) حمل

جواب: ج

بخش ب: سؤالات کوتاه - ۵ سؤال

۱. BHC برای چند نفر است؟

جواب: برای هر ۱۵,۰۰۰-۳۰,۰۰۰ نفر (در ساحات بسیار دور، کمتر از ۱۵,۰۰۰ نفر).

۲. Variance محاسبه می‌شود؟

جواب: Planned - Actual.

۳. Incident Report چه بخش‌هایی است؟

جواب: تاریخ، مکان، شرح حادثه، افراد متأثر، اقدام فوری، اقدام بعدی.

۴. Action Plan چه ستون‌هایی دارد؟

جواب: مشکل، اقدام، مسئول، زمان، شاخص موفقیت.

۵. PSEA چه گزارشی می‌شود؟

جواب: فوراً به دفتر مرکزی و مسئول PSEA - محرمانه حفظ می‌شود.

بخش ج: سناریو - ۱ سؤال

تمرین کوتاه

BHC اشتراکی دوا دریافت نکرده و راه‌ها در حال بسته شدن است. چه می‌کنی؟
تو Coordinator ولایت دایکندی هستی. در ماه قوس هستی.

جواب مدل

مرکزی اطلاع می‌دهم. از تجربه درس می‌گیرم - باید از ماه میزان شروع می‌کردم.
است، باید فوراً فرستاده شود؛ اگر ممکن نباشد، از PPHD کمک می‌خواهم. به دفتر فوراً با تدارکات تماس می‌گیرم. اگر دوا موجود

Sample Answer

I would immediately contact logistics to send the medicine urgently. If not possible, I would request support from PPHD. I would inform the central office and document the lesson learned: winterization planning must start in Mizan, not Qaws.

بخش د: راپور نویسی - ۱ سؤال

HMIS؛ Drug Availability: ۸۰٪؛ ۳ کلینیک Stock Card به‌روز نداشتند.
راپور ماهوار بنویس. معلومات: نظارت از ۴ BHC؛ Reporting Rate: ۸۵٪

سؤال.

Stock Card به روز نداشتند. ۵. پلان آینده: پیگیری Stock Card تا ۱۰ ثور.
 HMIS Reporting Rate: ۴؛ ۸۰٪ Drug Availability. مشکلات: ۳ کلینیک
 فعالیت‌ها: نظارت از ۴ BHC در ولسوالی‌های نیلی و شهرستان. ۳. نتایج: ۸۵٪
 راپور فعالیت‌های صحتی ولایت دایکندی را در ماه حمل ۱۴۰۵ پوشش می‌دهد. ۲.
 راپور ماهوار - Coordinator ولایت دایکندی - ماه حمل ۱۴۰۵: ۱. مقدمه: این
 جواب:

مشکل	اقدام	مسئول	زمان
Stock Card	پیگیری + آموزش	Coordinator	۱۰ ثور
دیر HMIS	آموزش کارمند	HMIS Officer	۱۵ ثور

آزمون آزمایشی ۳

بخش الف: ۱۰ - MCQ سؤال

چه خدماتی ارائه می‌دهد؟ ۱. EPHS

الف) خدمات صحت اولیه

• ب) خدمات شفاخانه‌ای

• ج) خدمات قریه

• د) خدمات واکسین

جواب: ب

مخفف چیست؟ ۲. PPHD

الف) Provincial Public Health Directorate

• ب) Public Private Health Department

• ج) Primary Public Health Division

• د) Provincial Primary Health Directorate

جواب: الف

دوا ۳۰۰ دانه است؛ موجودی ۶۰۰ دانه. برای چند ماه کافی است؟ AMC. ۳.
یک

الف) ۱ ماه

• ب) ۲ ماه

• ج) ۳ ماه

• د) ۴ ماه

جواب: ب

شامل کدام است؟ Supporting Documents. ۴.

الف) فقط فاکتور

• ب) فاکتور، رسید، قرارداد

• ج) فقط راپور

• د) فقط ایمیل

جواب: ب

در کدام ولایت فعال نیست؟ SO. ۵.

الف) دایکندی

• ب) بامیان

• ج) هرات

• د) غزنی

جواب: ج

اصل دوم چیست؟ PSEA. ۶.

الف) عدم تحمل مطلق

• ب) ممنوعیت روابط با افراد زیر ۱۸ سال

• ج) گزارش الزامی

• د) محرمیت

جواب: ب

معلومات به کجا فرستاده می‌شود؟ HMIS. ۷.

الف) فقط دفتر مرکزی

• ب) PPHD/NGO - بعد مرکز

• ج) فقط جامعه

• د) فقط شفاخانه

جواب: ب

یک دوا ۹۰۰ دانه است؛ موجودی ۸۰۰ دانه. چه می‌کنی؟ Reorder Point ۸.

الف) هیچ

• ب) فوراً سفارش بده

• ج) منتظر بمان

• د) به PPHD اطلاع بده

جواب: ب

چقدر طول دارد؟ Executive Summary ۹.

الف) ۵ صفحه

• ب) ۳ صفحه

• ج) نصف صفحه

• د) ۱۰ صفحه

جواب: ج

چطور رفتار می‌کند؟ PPHD در جلسه Coordinator ۱۰.

الف) خاموش می‌نشیند

• ب) مشکل را واضح می‌گوید + راه حل پیشنهاد می‌کند

• ج) فقط گوش می‌دهد

• د) جلسه را ترک می‌کند

جواب: ب

بخش ب: سؤالات کوتاه - ۵ سؤال

چيست؟ Physical Count ۱.

جواب: شمردن فزیکتی موجودی دوا.

چیسٲ Advance Clearance ۲.

جواب: تصفیه Advance با اسناد حمایتی.

شامل چه بخش‌هایی است؟ Incident Report ۳.

جواب: تاریخ، مکان، شرح، افراد متأثر، اقدام فوری، اقدام بعدی.

اصل پنجم چیسٲ PSEA ۴.

جواب: گزارش الزامی هر نوع ادعا/شکایت، سوء ظن یا خطر.

چیسٲ Winterization ۵.

جواب: آمادگی قبل از زمستان برای رساندن دوا به مراکز دورافتاده.

بخش ج: سناریو - ۱ سؤال

تمرین کوتاه

هستی. یک کارمند متهم به رفتار نادرست با یک مریض زن شده. چه می‌کنی؟
تو Coordinator ولایت دایکندی

جواب مدل

می‌شود؛ مطابق پالیسی اقدام می‌شود؛ هیچ تصمیمی بدون تحقیق گرفته نمی‌شود.
کار کنار گذاشته می‌شود؛ مریض حمایت روانی و صحت می‌شود؛ تحقیق محرم انجام
حفظ می‌کنم؛ فوراً به دفتر مرکزی و مسئول PSEA اطلاع می‌دهم؛ کارمند موقتاً از
محرمیت

Sample Answer

I would maintain confidentiality, immediately report to the central office
and PSEA focal point, suspend the employee pending investigation,
ensure the survivor receives support, and follow policy for investigation
and action.

بخش د: مصاحبه - ۵ سؤال

۱. خودت را معرفی کن.

دارم و می‌خواهم در SO به عنوان Coordinator ولایتی دایکندی خدمت کنم.»
و هماهنگی با PPHD آشنا هستم. من به کار تیمی، شفافیت و پاسخگویی باور
بخش صحت دارم. من در [سابقه کاری] کار کرده‌ام و با HMIS، نظارت، تدارکات
جواب: «نام من [نام] است. من [تحصیلات] دارم و [چند] سال تجربه در

Sample Answer

My name is [Name]. I have a degree in [field] and [X] years of experience in the health sector. I have worked in [previous roles] and I am familiar with HMIS, monitoring, procurement, and coordination with PPHD. I believe in teamwork, transparency, and accountability, and I am eager to serve as Provincial Coordinator for SO in Daikundi.

۲. چرا می‌خواهی در SO کار کنی؟

به مردم خدمت کنم و بخشی از تیمی باشم که برای فردای بهتر کار می‌کند.»
- شفافیت، پاسخگویی و حساسیت جنسیتی - باور دارم. می‌خواهم در دایکندی
صحت، آموزش و توانمندسازی زنان تمرکز دارد. من به مأموریت و ارزش‌های SO
جواب: «SO در ۱۹۸۹ تأسیس شده و بر

Sample Answer

SO was founded in 1989 with a focus on health, education, and women's empowerment. I believe in SO's mission and values - transparency, accountability, and gender sensitivity. I want to serve the people of Daikundi and be part of a team working for a better tomorrow.

۳. اگر یک مشکل بزرگ پیش بیاید، چه می‌کنی؟

می‌کنم؛ به دفتر مرکزی و PPHD راپور می‌دهم؛ پیگیری می‌کنم تا حل شود.»
اگر فوری است، اقدام فوری می‌کنم؛ به مسئول مربوط اطلاع می‌دهم؛ مستند
جواب: «اول مشکل را بررسی می‌کنم؛ با منبع اصلی چک می‌کنم؛

Sample Answer

First, I would verify the issue. I would check against the source. If urgent, I would take immediate action. I would inform the relevant person, document it, report to the central office and PPHD, and follow up until resolved.

۴. چطور با تیم کار می‌کنی؟

با هم حل می‌کنیم. من از تجربه تیم یاد می‌گیرم و تجربه‌ام را شریک می‌کنم. من هماهنگ می‌کنم، راهنمایی می‌دهم و پیگیری می‌کنم. اگر مشکلی باشد، جواب: «من به کار تیمی باور دارم. هر کارمند مسئولیت مشخص دارد.»

Sample Answer

I believe in teamwork. Each staff member has clear responsibilities. I coordinate, guide, and follow up. If there is a problem, we solve it together. I learn from the team and share my experience.

۵. چطور PSEA را رعایت می‌کنی؟

و مریضان ایجاد می‌کنم. اگر چیزی ببینم یا بشنوم، فوراً گزارش می‌دهم. حمایت از قربانی. من به عنوان Coordinator، محیط امن برای کارمندان را می‌دانم: عدم تحمل مطلق در برابر رفتار نادرست، گزارش الزامی، محرمانه، جواب: «من اصول PSEA

Sample Answer

I know the PSEA principles: zero tolerance, mandatory reporting, confidentiality, and survivor support. As Coordinator, I create a safe environment for staff and patients. If I see or hear anything, I report immediately.

۱۰.۱ خلاصه ۶۰ ثانیه‌ای

• آزمون آزمایشی ۱: MCQ + کوتاه + سناریو + محاسبه.

- آزمون آزمایشی ۲: MCQ + کوتاه + سناریو + راپور.
- آزمون آزمایشی ۳: MCQ + کوتاه + سناریو + مصاحبه.
- در هر سناریو، هفت کلمه طلایی را به کار ببر.
- در مصاحبه، خودت را معرفی کن، از SO بگو، از تجربیات بگو.
- خط سرخ؛ هیچ استثنایی نیست = PSEA

← مستند کن ← اقدام کن ← اولویت بده ← بررسی کن ← هفت کلمه طلایی: بفهم
پیگیری کن ← راپور بده

جواب‌های طلایی فصل دهم

سؤال احتمالی	جواب طلایی (دری)	Sample Answer (English)
خودت را معرفی کن	مهارت‌ها، باور به کار تیمی نام، تحصیلات، تجربه،	Name, education, experience, skills, belief in teamwork.
چرا SO؟	خدمت به مردم دایکندی مأموریت، ارزش‌ها،	Mission, values, service to Daikundi people.
اگر مشکل بزرگ پیش بیاید؟	کن، راپور بده، پیگیری کن بررسی کن، اقدام کن، مستند	Verify, act, document, report, and follow up.
چطور با تیم کار می‌کنی؟	پیگیری، حل مشکل با هم هماهنگی، راهنمایی،	Coordinate, guide, follow up, and solve problems together.
چطور رعایت می‌کنی؟ PSEA	+ گزارش الزامی + محرمت عدم تحمل مطلق	Zero tolerance + mandatory reporting + confidentiality.
در جلسه Coordinator چطور رفتار می‌کنی؟ PPHD	+ راه حل پیشنهاد می‌کند مشکل را واضح می‌گوید	Clearly presents the issue and proposes solutions.

نکته آخر فصل دهم

بلد باشی، برای امتحان واقعی آماده‌ای. هفت کلمه طلایی را در هر جواب به کار ببر.
این سه آزمون آزمایشی را تمرین کن؛ اگر این‌ها را

پایان کتاب - پیام آخر

است که فکر می‌کند، تصمیم می‌گیرد و پیگیری می‌کند Provincial Coordinator کسی.

اگر فقط معلومات جمع کنی و بفرستی، منشی هستی.

اگر فکر کنی، اولویت بدهی، اقدام کنی و پیگیری کنی - Coordinator هستی.
بفهم (Understand)

بررسی کن (Verify)

اولویت بده (Prioritize)

اقدام کن (Act)

مستند کن (Document)

راپور بده (Report)

پیگیری کن (Follow Up)

موفق باشی!

Working for a better tomorrow

پیوست ۱: واژه‌نامه دری-انگلیسی

کدام شکل‌ها (معمولاً ایرانی یا ترجمه ماشینی) در این کتاب به کار نرفته است. کن تا نوشته‌ات یکدست بماند. ستون «شکل نادرست/غیرمرجح» نشان می‌دهد به کار رفته است. وقتی راپور یا ایمیل می‌نویسی، همین شکل‌ها را استفاده کتاب است: هر اصطلاح یک بار اینجا تصویب شده و در همه فصل‌ها همان شکل این واژه‌نامه معیار اصطلاحات

اصطلاح دری (مرجح)	انگلیسی	اختصار	غیرمرجح / توضیح شکل
مراقبت پیش از ولادت	Antenatal Care	ANC	هم می‌توان اشاره کرد یا «معاینه زن باردار» در راپور، به ANC «مراقبت بارداری»؛
مراقبت بعد از ولادت	Postnatal Care	PNC	—
بخش سرپایی	Out-Patient Department	OPD	OPD نادرست است «درمانگاه» در معنی
مرکز صحتی اساسی	Basic Health Center	BHC	بهداشتی «ایرانی» مرکز
مرکز صحتی جامع	Comprehensive Health Center	CHC	—
مرکز صحتی فرعی	Sub Health Center	SHC	—
صحتی / پست صحتی خانه	Health Post	HP	بهداشت «ایرانی» خانه
شفاخانه ولسوالی	District Hospital	DH	شهرستان «ایرانی» بیمارستان
شفاخانه ولایتی	Provincial Hospital	PH	استانی «ایرانی» بیمارستان
تیم صحتی سیار	Mobile Health Team	MHT	—
صحتی جامعه (صحیار) کارمند	Community Health Worker	CHW	«بهورز» «ایرانی»

اصطلاح دری (مرجع)	انگلیسی	اختصار	غیرمرجع / توضیح شکل
قابلہ	Midwife	—	«ماما» (ایرانی)
شورای صحت	Health Shura / Health Council	—	بهداشت «ایرانی» «انجمن»
صحت عامه ولایت ریاست	Provincial Public Health Directorate	PPHD	استان «ایرانی» «اداره بهداشت»
وزارت صحت عامه	Ministry of Public Health	MoPH	بهداشت «ایرانی» «وزارت»
هماهنگی صحتی ولایت کمیته	Provincial Public Health Coordination Committee	PPHCC	—
خدمات صحتی اساسی بسته	Basic Package of Health Services	BPHS	—
اساسی شفاخانه‌ای بسته خدمات	Essential Package of Hospital Services	EPHS	—
مدیریت صحتی سیستم معلومات	Health Management Information System	HMIS	—
(دفتر ثبت مریضان) ثبت	Register	—	(Source Document) منبع اصلی معلومات
کارت ثبت موجودی	Stock Card	—	به کار نرفته است انبار» در این کتاب «کارت»
فیزیکی موجودی شمردن	Physical Count	—	—
مصرف متوسط ماهوار	Average Monthly Consumption	AMC	—
نقطه سفارش مجدد	Reorder Point	—	—
ذخیره احتیاطی	Safety Stock	—	«ذخیره امنیتی»

اصطلاح دری (مرجع)	انگلیسی	اختصار	غیرمرجع / توضیح شکل
کمبود دوا	Stock-out	—	«فقدان دارو»
تاریخ انقضا	Expiry Date	—	مصرف « مبهم است «تاریخ انقضاً»؛ «تاریخ
زنجیره سرد	Cold Chain	—	—
زمستانی‌سازی	Winterization	—	—
تدارکات	Procurement / Logistics	—	—
درخواست خرید	Purchase Requisition	PR	«درخواست خریداری»
دارایی‌ها	Assets	—	—
ثبت دارایی	Asset Register	—	—
بودجه	Budget	—	—
تفاوت بودجه	Variance	—	—
پیش‌پرداخت	Advance	—	—
تصفیه پیش‌پرداخت	Advance Clearance	—	«تسویه» (ایرانی)
اسناد حمایتی	Supporting Documents	—	در این معنی «مستندات»
پول نقد	Cash	—	—
حسابرسی	Audit	—	«ممیزی» (ایرانی)
شرح وظایف	Terms of Reference	ToR	ترجمه لفظی است «شرایط مرجع»
اعلان وظیفه	Vacancy Announcement	VA	استخدام» (ایرانی) «آگهی
لیست کوتاه	Shortlisting	—	—
حاضری	Attendance	—	و غیاب» (ایرانی) «حضور
رخصتی	Leave	—	«مرخصی» (ایرانی)
رخصتی زایمان	Maternity Leave	—	—

اصطلاح دری (مرجع)	انگلیسی	اختصار	غیرمرجع / توضیح شکل
ارزیابی عملکرد	Performance Evaluation	—	—
روند اجراات	Disciplinary Process	—	اداری» در این معنی «تخلفات
محرمیت	Confidentiality	—	«محرمانگی» (ایرانی)
اجرائیه	Executive Board	—	—
عالی صحت عامه شورای	High Council of Public Health	—	—
Stakeholder	Stakeholder	—	«شریک/طرف مربوط» همان Stakeholder یا لفظی) - در متن دری، «ذی‌نفعان» (ترجمه
Service Provider	Service Provider	SP	در متن این کتاب «سازمان تطبیق‌کننده»
رپور ماهوار	Monthly Report	—	ماهانه» (ایرانی) «گزارش
رپور ربعوار	Quarterly Report	—	فصلی» (ایرانی) «گزارش
رپور روایتی	Narrative Report	—	—
خلاصه اجرائی	Executive Summary	—	—
پلان اقدام	Action Plan	—	عملیاتی» (ایرانی) «برنامه
رپور حادثه‌ای	Incident Report	—	—
شاخص کلیدی عملکرد	Key Performance Indicator	KPI	—
خطر	Risk	—	است اتفاق بیفتد چیزی که ممکن
مشکل	Issue	—	که قبلاً اتفاق افتاده چیزی

اصطلاح دری (مرجع)	انگلیسی	اختصار	غیرمرجع / توضیح شکل
/ بالا بردن مشکل تشدید	Escalation	—	—
نظارت	Monitoring	—	در جریان کار
ارزیابی	Evaluation	—	بعد از تمام شدن کار
پیگیری	Follow-up	—	—
اولویت بندی	Prioritization	—	—
و سوء استفاده جنسی حفاظت از استثمار	Protection from Sexual Exploitation and Abuse	PSEA	—
گزارش الزامی	Mandatory Reporting	—	—
عدم تحمل مطلق	Zero Tolerance	—	—
شفافیت	Transparency	—	—
پاسخگویی	Accountability	—	—
حساسیت جنسیتی	Gender Sensitivity	—	—
توانمندسازی زنان	Women Economic Empowerment	WEE	—

●> حفظ کن

نوشتی و فردا «کلینیک اساسی»، خواننده فکر می کند دو چیز متفاوت است.
یک اصطلاح را همیشه به یک شکل بنویس. اگر امروز «مرکز صحتی اساسی»
< در راپور و ایمیل رسمی،

پیوست ۲: قالب‌های کاری و چک‌لیست‌ها

داده شده - پس اگر قالب را پر می‌کنی، در واقع روش کار را به کار می‌بری. خود نگه داری. هر قالب، همان چیزی است که در فصل‌های این کتاب تعلیم این پیوست را می‌توانی چاپ کنی و در فایل کاری

چک‌لیست نظارت از یک مرکز صحت (Monitoring Visit)

۲.۱

پیش از سفر:

- نظارت را در پلان ماهوار خود ثبت کن و به مسئول کلینیک از قبل اطلاع بده.
 - تاریخ و هدف
 - ماه گذشته همان کلینیک (HMIS) را بخوان؛ اعداد مشکوک را یادداشت کن.
 - راپور
 - چک‌لیست شاخص‌های مورد نظر خود را آماده کن (حداقل ۱۰ شاخص).
 - کار: چک‌لیست چاپ‌شده، قلم، دفتر، وسایل حفاظتی در صورت ضرورت.
 - وسایل
- در جریان نظارت:

بخش	چه چیز را چک می‌کنی؟	منبع
ثبت معلومات	OPD، ولادت، TB، واکسین) کامل بودن Register ها (ANC)	دفتر ثبت
دوا	زنجیره سرد، Stock Card، تاریخ انقضا، موجودی فیزیکی،	و یخچال Stock Card
کارمندان	کلیدی (قابله، واکسیناتور) حاضری، موجودیت پرسونل	برگه حاضری
خدمات	ساعت کاری، نظافت و ترتیب ارائه خدمات اساسی،	مشاهده مستقیم
مریضان	رضایت مریض، شکایات احترام، محرمیت،	گفتگو با مریضان

منبع	چه چیز را چک می‌کنی؟	بخش
دفتر ارجاع	سیستم ارجاع و ثبت ارجاع‌ها موجودیت	مرجع
راپور و دفتر ثبت	راپور ماه گذشته با Register تطابق	HMIS

بعد از نظارت (همان روز):

- با مسئول کلینیک جلسه کوتاه بگیر: یافته‌ها، اقدام لازم، مسئول، مهلت. پلان اقدام را در راپور نظارت بنویس (مشکل، اقدام، مسئول، زمان، شاخص).
- راپور نظارت را به PPHD و دفتر مرکزی بفرست.
- تاریخ پیگیری بعدی را در پلان کاری خودت ثبت کن.

۲.۲ قالب راپور ماهوار

راپور ماهوار — دفتر ولایتی [نام ولایت] — ماه [نام ماه] ۱۴۰۵

۱. مقدمه (۲-۳ سطر): فعالیت‌های صحنی ولایت ... را در ماه ... پوشش می‌دهد. این راپور
۲. فعالیت‌های انجام‌شده: راپور HMIS از ... مرکز؛ پیگیری تدارکات برای ... مرکز. نظارت از ... مرکز؛ جلسات با PPHD (... جلسه)؛ جمع‌آوری
۳. نتایج و شاخص‌ها (جدول):

شاخص	این ماه	ماه قبل	تغییر
HMIS Reporting Rate			
Drug Availability			
Supervised facilities			
Attendance Rate			

۴. مشکلات و علت آن‌ها: بنویس (تخنیکی، نبود کارمند، امنیتی، تأخیر تدارکات). برای هر مشکل یک سطر علت

۵. درس‌های آموخته‌شده: یک یا دو درس عملی که ماه بعد به کار می‌گیری.

۶. پلان ماه آینده: فعالیت، مسئول، زمان.

۷. پلان اقدام:

مشکل	اقدام	مسئول	زمان	شاخص موفقیت
------	-------	-------	------	-------------

۸. ضمیمه‌ها: راپور نظارت، جدول حاضری (اگر جداگانه فرستاده نمی‌شود).
راپور HMIS،

۲.۳ قالب راپور حادثه‌ای (Incident Report)

بخش	چیزی که باید بنویسی
تاریخ و وقت دقیق	روز، ساعت، شمسی و میلادی
مکان	ولایت، ولسوالی، مرکز صحتی، محل دقیق
نوع حادثه	مرگ کارمند، تخلف PSEA، رویداد طبیعی امنیتی، صحتی، آتش‌سوزی، دزدی،
شرح حادثه	کسی حاضر بود - بدون حدس و بدون قضاوت چه اتفاق افتاد، چطور، چه
افراد متأثر	مریضان، کارمندان، تیم؛ وضعیت صحتی آن‌ها
اقدام فوری	چه کار کردی، در چه وقت، با کی
اطلاعات به کی داده شد	مرکزی، مقامات محلی (با ذکر وقت، PPHD، (دفتر)
اقدام بعدی	پلان، مسئول، زمان
ضمیمه‌ها	عکس، راپور صحتی، اظهارات (اگر موجود باشد)

➤ حفظ کن

تکمیلی بعداً فرستاده می‌شود». خاموش ماندن، خطرناک‌ترین انتخاب است.
کامل نیست، راپور اولیه را با همان معلومات موجود بفرست و بنویس «معلومات
< راپور حادثه‌ای همان روز فرستاده می‌شود. اگر معلومات

۲.۴ کاربرد محاسبه AMC و Reorder Point

ماه	مصرف یک دوا (دانه/بوتل)
ماه اول	
ماه دوم	
ماه سوم	
مجموع سه ماه	
(مجموع ۳) AMC	
زمان تحویل (ماه)	
ذخیره احتیاطی (ماه)	
Reorder Point = (AMC × زمان تحویل) + (ذخیره احتیاطی × AMC)	
موجودی فعلی	
اقدام	اگر موجودی $\geq$ Reorder Point → سفارش فوری

چک لیست تصفیه پیش پرداخت (Advance Clearance)

۲.۵

- درخواست پیش پرداخت با مبلغ و هدف فعالیت - تایید شده.
- فاکتور یا رسید خرید (به نام سازمان، با تاریخ و شماره).
- برگه حاضری یا لیست اشتراک کنندگان (اگر برنامه آموزشی/جلسه بوده).
- راپور فعالیت یا راپور سفر (اگر مربوط به نظارت بوده).
- جدول مصرف: مبلغ اخذ شده، مبلغ مصرف شده، باقی مانده.
- باقی مانده پول: برگشت به صندوق یا ثبت در سند رسمی.
- امضای مسئول مالی و Coordinator.
- ثبت در سیستم مالی و نگهداری کپی در فایل فعالیت.

۲.۶ قالب پلان کاری ماهوار

هفته	فعالیت	مسئول	وسیله / ساحه	تاریخ	تطبیق شاخص
۱					

هفته	فعالیت	مسئول	وسیله / ساحه	تاریخ	تطبیق شاخص
۲					
۳					
۴					

۲.۷ قالب صورت جلسه کوتاه (Minutes)

- تاریخ، وقت، مکان؛ اشتراک کنندگان (نام و وظیفه).
- اجندا (۳-۵ نقطه).
- تصمیم‌ها: هر تصمیم با مسئول و مهلت.
- مطالبات از سازمان تو و از PPHD (جدا جدا).
- تاریخ جلسه بعدی و تاریخ فرستادن صورت جلسه.

پیوست ۳: پلان ۹۰ روزه اول کار

- اگر تازه به این بست گماشته شده‌ای، این پلان را روی دیوار دفتر خود بچسبان.
- روزهای ۱-۳۰: بفهم
- Stock Card ها، فایل‌های HR، اسناد مالی، فهرست مراکز صحتی زیر پوشش.
 - ملاقات با Coordinator قبلی و تحویل‌گیری وظیفه: اسناد، راپورها،
 - معرفی رسمی به PPHD ولایت و گرفتن فهرست نقاط تماس.
 - جلسه با تیم ولایتی: چه کسی چه کار می‌کند، کدام مشکل فوری است.
 - خواندن راپورهای سه ماه گذشته: کدام شاخص ضعیف است؟
 - بازدید از دو مرکز صحتی نزدیک برای شناخت واقعیت ساحه.
 - مشکلات فوری (زندگی مردم، خدمات اساسی) و راپور آن به دفتر مرکزی.
 - تهیه فهرست
- روزهای ۳۱-۶۰: سازماندهی کن
- پلان کاری ماهوار با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری.
 - یک چرخه کامل نظارت: بازدید، راپور، پلان اقدام، پیگیری.
 - چک کردن وضعیت HMIS: کدام مراکز راپور نمی‌دهند و چرا.
 - کردن Stock Card ها و ساختن پلان زمستانی/تدارکاتی برای مراکز دورافتاده.
 - چک
 - جلسه با شورای صحتی یک قریه و شنیدن مشکلات جامعه.
 - فایل‌های HR و حاضری منظم اند و مسئول PSEA در ولایت معلوم است.
 - مطمئن شدن از اینکه
- روزهای ۶۱-۹۰: نتیجه بده
- یک بهبود قابل اندازه‌گیری نشان بده (مثلاً Reporting Rate از ۸۰٪ به ۹۵٪).
 -
 - را با PPHD و دفتر مرکزی حل کن (مثلاً کمبود قابله در یک ولسوالی).
 - یک مشکل ساختاری
 - راپور ربعوار را با تحلیل - نه فقط لیست - بنویس.

• بازیابی خودت: کدام سه کار را باید دفعه بعد بهتر انجام بدهی؟

پیوست ۴: راهنمای امتحان و مصاحبه

ساختار جواب در سناریو (در هر سناریو همین ترتیب):

۱. افوری: آیا جان کسی در خطر است؟ اگر بله، همین را اول بگو.

۲. بررسی: را با منبع اصلی (Register، Stock Card، حاضری) چک می‌کنم. معلومات

۳. اولویت: کدام کار اول، چرا.

۴. اقدام: چه کسی، چه کار، تا کی.

۵. مستندسازی و راپور: ثبت و به PPHD و دفتر مرکزی اطلاع می‌دهم. در راپور نظارت/حادثه‌ای

۶. پیگیری: تاریخ پیگیری مشخص می‌کنم و نتیجه را چک می‌کنم.

جمله‌های کلیدی که امتیاز می‌گیرند:

• «اول جان مریض و تداوم خدمات اساسی؛ بعد راپور و جلسات.»

• «معلومات را با منبع اصلی مقایسه می‌کنم، نه با راپور قبلی.»

• «هر مشکل باید اقدام، مسئول، زمان و شاخص داشته باشد.»

در PSEA، محرمانه را حفظ می‌کنم و فوراً از کانال رسمی گزارش می‌دهم. «در صورت شک

«اگر از توان من بالاتر بود، Escalate می‌کنم - اما اول خودم تلاش می‌کنم.»

.

سؤال‌های متداول مصاحبه (با یک سطر راهنما):

سؤال	راهنمای جواب
خودت را معرفی کن	مهارت قوی، علاقه به کار تیمی - در یک دقیقه نام، تحصیلات، تجربه کاری مرتبط، دو
چرا این بست را می‌خواهی؟	تجربیات با وظایف بست، خدمت به مردم ولایت مأموریت سازمان، ارتباط
یک مشکل را چطور حل کردی؟	یک مثال واقعی با ساختار: موقعیت ← بررسی ← اقدام ← نتیجه ← درس

سؤال	راهنمای جواب
اگر راپور HMIS ناقص باشد چه می‌کنی؟	را پیدا کن، جمع کن، اطلاع بده، پیگیری کن علت
اگر دوا تمام شود چه می‌کنی؟	کن، علت را با Stock Card پیدا کن، پیگیری کن فوری حل
با PPHD چطور هماهنگ می‌کنی؟	جلسات، راپور منظم، طرح مشکلات با راه‌حل
چیست و چطور رعایت می‌کنی؟ PSEA	محرمیت، گزارش فوری، حمایت از قربانی اصول شش‌گانه IASC،
ضعف خودت چیست؟	ضعف واقعی + کاری که برای بهبود آن می‌کنی یک
چه سؤالی از ما داری؟	شاخص‌های موفقیت بست یا سه ماه اول کار یک سؤال جدی در مورد تیم،

پیوست ۵: منابع و مراجع

- شده است. برای راپورها و کار روزمره، نسخه‌های به‌روز همین منابع معیار است. این کتاب بر اساس اسناد و منابع زیر تهیه و تصحیح
۱. وزارت صحت عامه افغانستان (MoPH) ولایتی (۲۰۰,۰۰۰-۵۰۰,۰۰۰ نفر).
۳۰,۰۰۰-۶۰,۰۰۰ CHC (نفر)، شفاخانه ولسوالی (۱۰۰,۰۰۰-۳۰۰,۰۰۰ نفر) و شفاخانه معیار جمعیتی (۱,۵۰۰-۱,۰۰۰ Health Post (نفر)، (۳۰,۰۰۰-۱۵,۰۰۰ BHC (نفر)، - «بسته خدمات صحتی اساسی (BPHS)»، نسخه ۲۰۱۰:
 ۲. وزارت صحت عامه افغانستان ماه؛ راپور ربعوار - تا پایان ماه اول ربع جدید. مهلت فرستادن راپور تلفیقی ماهانه به PPHD/سازمان - قبل از هفتم هر - «رهنمای روند (HMIS Procedures Manual) (HMIS)»:
 ۳. وزارت صحت عامه افغانستان صفحه «General Directories». خدمات صحتی، پالیسی و انکشاف، طب و غذا، مالی و اداری) - moph.gov.af، - ساختار وزارت و ریاست‌های عمومی (چهار معینیت):
 ۴. سازمان جهانی صحت (WHO EMRO, Health Systems) - مردم در فاصله دو ساعته به خدمات صحتی دسترسی داشتند: «Afghanistan» در سال ۲۰۱۸ در افغانستان ۳,۱۳۵ مرکز صحتی فعال بود و نزدیک به ۸۷٪
 ۵. «Six Core Principles Relating to Sexual Exploitation and Abuse» (PSEA با بازبینی‌های بعدی): مبنای بخش، ۲۰۰۲) -
 ۶. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد (UNICEF) و نظارت MoPH و PPHD. صحت اولیه) و WHO (خدمات شفاخانه‌ای) با همکاری Service Provider ها «Health»: مدیریت قراردادهای BPHS/EPHS از سوی UNICEF (خدمات - ارزیابی برنامه «Emergency Response / Novel Financing Arrangement»
 ۷. گزارش‌های وضعیت صحتی افغانستان (۲۰۲۴-۲۰۲۵) عامه تا پایان ۲۰۲۶. - کاهش تعداد مراکز صحتی فعال پس از ۲۰۲۱ و تمدید کمک‌های صحتی
 ۸. Shuhada Organization و توانمندسازی زنان در ولایات مرکزی افغانستان). سالانه سازمان (تأسیس ۱۹۸۹ در کوئته، پاکستان؛ فعالیت در صحت، آموزش - تاریخچه، مأموریت و گزارش‌های

>● حفظ کن

«منبع: Register کلینیک، ماه حمل ۱۴۰۵». راپور بدون منبع، قابل دفاع نیست.
راپور رسمی، همیشه بنویس که معلومات از کدام منبع و کدام دوره است - مثلاً
< در

درباره این نسخه

نام کتاب: قانون زبان – راهنمای جامع و عملی Provincial Coordinator

ناشر/تهیه کننده: دفتر ولایتی دایکندی – Shuhada Organization

نسخه: دوم – ویرایش شده، تصحیح شده و آماده نشر

سال: ۱۴۰۵ خورشیدی

زبان: دری (افغانی) با اصطلاحات انگلیسی در متن

سلسله نسخه‌ها: نسخه اصلی دریافت شده ← نسخه کاری ← تصحیح شده علمی نسخه ← نسخه ویرایش شده زبانی ← هرگز تغییر نکرده و نگهداری می‌شود. نسخه نهایی (منبع تولید PDF، DOCX و EPUB). نسخه اصلی

روش ویرایش این نسخه: در «لاگ تغییرات ویرایشی» ثبت شده است. پیوست‌های کاری، واژه‌نامه و فهرست منابع جدید اضافه شد. تمام تصحیحات به هر فصل «اهداف این فصل» اضافه شد؛ بخش ۳.۸ (نظام صحت امروز)، شد؛ اصطلاحات افغانی یکدست شد؛ نیم‌فاصله، نقطه‌گذاری و اعداد نظم گرفت؛ کتاب بازبینی شد؛ معیارهای صحت و اداری با منابع معتبر مقایسه و تصحیح ساختار

پیشنهاد و اصلاح: شماره فصل و بخش، متن فعلی، متن پیشنهادی، و منبع. Shuhada اطلاع بده تا در نسخه بعدی اصلاح شود. شکل درست اصلاح: رسمی PPHD/MoPH تفاوت داشت، آن را از راه دفتر ولایتی Shuhada Organization است. اگر در کار خود به معلومات تازه‌تری رسیدی، یا جایی از کتاب با دستور این کتاب یک سند زنده

یادآوری: وزارت صحت عامه، پالیسی سازمان و هدایت PPHD معیار نهایی است. کتاب راهنمای آموزشی است. در تصمیم‌های کلینیکی و اداری، راهنمای رسمی این